ANÁLISIS DE EMPRESA COTIZADA

UnitedHealth Group Incorporated

UNH · New York Stock Exchange · ISIN US91324P1021 · Health Care

Fecha de corte de los datos: **12 oct 2026** · Divisa: **USD** · Cifras en **millones**

Recomendación **Mantener**	Precio **379,30 USD**	Objetivo 12 m **469,09 USD**	Rentabilidad 12 m **+26,0 % (base +26,0 %)**
Valor intrínseco **371,62 USD · mercado 435,72**	Convicción **Baja**	Capitalización **341.977 M**	EV/EBITDA próx. 12 m **13,1x**
Deuda neta aj. / EBITDA **2,7x**			

Nombre	**UnitedHealth Group Incorporated**	Ticker / ISIN	**UNH / US91324P1021**
Mercado	**New York Stock Exchange**	Índice de referencia	**S&P 500**
Sector / industria	**Health Care / Health Care Providers & Services (Managed Health Care)**	Sede · fundación	**Eden Prairie (Minnesota) · 1977**
Empleados	**390.000**	Web	**www.unitedhealthgroup.com**
Precio (fecha)	**379,30 (9 oct 2026)**	Rango 52 semanas	**255,97 – 461,62**
Acciones diluidas (M)	**901,6**		
Capitalización	**341.977 M USD**	Valor empresa	**422.707 M USD**
Volumen medio diario	**≈ 1.986 M USD/día (5,0 M de acciones, 3 meses)**	Próximos resultados	**13 oct 2026**

Contenido

- Síntesis y recomendación (una página)
- Resumen ejecutivo
- Parte I — Negocio y sector: 1. Historia · 2. Modelo de negocio · 3. Sector y mercado · 4. Posición competitiva
- Parte II — Finanzas: 5. Cuenta de resultados · 6. Resultados recientes · 7. Balance y circulante · 8. Flujos de caja · 9. Calidad contable · 10. Rentabilidad · 11. Deuda y solvencia · 12. Asignación de capital
- Parte III — Equipo y gobierno: 13. Equipo directivo · 14. Gobierno corporativo
- Parte IV — Mercado y valoración: 15. Consenso · 16. Bolsa · 17. Múltiplos históricos · 18. Comparables · 19. Transacciones · 20. DCF · 21. Escenarios · 22. Suma de partes · 23. Síntesis
- Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento: 24. Catalizadores · 25. Riesgos y pre-mortem · 26. ESG · 27. Preguntas abiertas · 28. Sentimiento en foros y comentarios
- Anexos: controles de calidad, información no disponible y fuentes
- Las secciones sin información verificable no se imprimen; quedan listadas en el anexo «Información no disponible».

No constituye recomendación de inversión.

Síntesis y recomendación

Mantener · Convicción Baja · Objetivo a 12 meses **469,09 USD** frente a 379,30 · Rentabilidad a 12 meses **+26,0 % (base +26,0 %)** · Valor intrínseco 371,62 USD · con la prima implícita del mercado: 435,72 (+14,9 %) · Alcista / bajista +37,2 % / -35,3 %

La recomendación y por qué. Mantener, con convicción baja. El valor objetivo es de 371,62 USD frente a un precio de 379,30 (cierre del 9-oct-2026), un −2,0 %; con el dividendo del 2,4 %, la rentabilidad total esperada a doce meses es del 0,3 %, y la asimetría de 1,05 veces (alcista +37,2 %, bajista −35,3 %) no compensa. La razón principal: el precio ya paga la recuperación del margen que esperan la empresa y el consenso, y nuestras cifras coinciden con ese consenso. La convicción es baja porque las dos reglas discrepan: con nuestro coste de capital sale Mantener, pero con la prima implícita del mercado el valor sube a 435,72 USD y la rentabilidad al 17,2 % (Comprar). La subiría un ratio de siniestralidad del 3T26 (13-oct) por debajo del 87 % sin ayuda de reservas, o un precio por debajo de 362,33 USD.

El negocio. UnitedHealth es la mayor aseguradora de salud de EE. UU. (26 % de Medicare Advantage, 16 % del seguro comercial) y, con Optum, el mayor grupo de servicios sanitarios [18, 29]. Ganó un ROIC del 18-21 % en 2017-2023; en 2025 cayó al 12,5 % porque el ratio de siniestralidad subió del 85,5 % al 89,1 % y Optum Health pasó a pérdidas [1]. Sigue por encima del WACC (8,92 %). La calidad de la empresa sostiene el crecimiento proyectado solo en parte: no necesita capital y tiene poder de precios con un año de retraso, pero pierde cuota en Medicare Advantage (del 29 % al 26 %) por decisión propia.

Sector y ciclo. El gasto sanitario de EE. UU. crecerá un 5,7 % anual hasta 2029 [17], pero la regulación aprieta: tarifa de Medicare Advantage del +2,48 % en 2027, ajuste de riesgo V28, reforma de los gestores de farmacia y recortes de Medicaid [25, 34]. Todo el sector está en mínimos de margen (Centene −3,9 %, Humana 2,1 % de margen EBIT en 2025) [22, 23].

Equipo y gobierno. Resta. Rotación casi total de la cúpula en 2025-2026, presidente y CEO de 73 años con una opción de 60 M USD, y un voto de remuneración del 60,0 % en 2025 [32, 40]. La guía de 2025 se incumplió (16,35 USD frente a 29,50-30,00); la de 2026 se ha subido dos veces [8, 10].

Valoración. El DCF da 415,08 USD (WACC 8,92 %, valor terminal 71 %); los escenarios ponderados, 398,95; el PER de los comparables, 275,37, y la suma de partes, 291,92. El DCF inverso dice que el precio descuenta un crecimiento del 3,2 % anual (frente a nuestro 4,6 %) o un margen EBITDA final del 7,5 % (frente a nuestro 8,0 %), es decir, una rentabilidad del 9,4 % anual, medio punto más que nuestro coste de capital. La distancia es de tasa de descuento, no de cifras. Comparables y suma de partes quedan por debajo del precio porque miden un 2026 deprimido.

Riesgos y catalizadores. El ratio de siniestralidad es la palanca: cada punto de margen EBITDA vale unos 73 USD por acción, y el bajista (margen del 6,5 % de 2025-2026 mantenido) lleva a 245,27. Las investigaciones del DOJ sobre Medicare Advantage son el riesgo binario sin fecha [30]. Catalizadores: resultados del 3T26 el 13-oct, guía de 2027 en enero y aviso de tarifas de 2028 a finales de enero [26, 68]. Los foros están divididos y los particulares venden; miran el 86,7 % del 2T26 cuando la guía anual es del 88,1 % [105, 106].

Qué cambiaría la decisión. Compraríamos por debajo de 362,33 USD y venderíamos por encima de 494,25. Pasaríamos a Comprar si la guía de 2027 apunta a un BPA ajustado por encima de 23 USD con el ratio de siniestralidad por debajo del 87 %, y a Vender si el ratio vuelve por encima del 89 % o el DOJ presenta cargos.

Resumen ejecutivo

Confianza: Media

Recomendación: Mantener · Convicción: Baja · Horizonte: 12 meses · Objetivo a 12 meses: **469,09 USD** (rentabilidad +26,0 % (base +26,0 %)) · Valor intrínseco: 371,62 USD (-2,0 % sobre 379,30) · con la prima implícita del mercado: 435,72 (+14,9 %)

UnitedHealth es la mayor empresa sanitaria de EE. UU.: 447.567 M USD de ingresos en 2025, el 26 % de Medicare Advantage y, con Optum, el mayor gestor de consultas médicas, tecnología sanitaria y uno de los tres grandes gestores de farmacia [1, 18]. Su valor está en la integración: cobra primas antes de pagar, apenas invierte (capex del 0,8 % de las ventas) y durante años convirtió eso en un ROIC del 18-21 %. En 2025 la subida del coste médico llevó el ratio de siniestralidad al 89,1 % y el margen EBITDA ajustado al 5,8 % [1].

A 379,30 USD, el precio descuenta una recuperación parcial: un margen EBITDA final del 7,5 %, frente al 6,6 % de la guía de 2026 y el 9,1-9,8 % de 2019-2024, o un crecimiento del 3,2 % anual. Cotiza a 18,4 veces el beneficio de los próximos doce meses, con prima del 37 % sobre la mediana de sus comparables (13,4x).

El mercado acierta en lo esencial. Nuestras cifras de 2026-2028 coinciden con el consenso y el valor que salen de ellas (415,08 USD en el DCF, 371,62 en la síntesis) está cerca del precio. Para invertir hay que creer que el ratio de siniestralidad vuelve al 86-87 % sin el apoyo de las reservas, que las tarifas de Medicare Advantage de 2028 no castigan y que las investigaciones del DOJ se cierran sin cambiar el modelo de codificación. Es posible, pero ya está en el precio.

La decisión

Elemento de la decisión	Valor
Objetivo a 12 meses (nuestro PER × nuestro BPA 2028e, ponderado 25/50/25)	469,09 USD
Bajista / base / alcista a 12 meses	16,0x × 16,33 = 261,28 · 20,0x × 23,45 = 469,00 · 23,9x × 28,33 = 677,09
Rentabilidad a 12 meses: ponderada / del base (con dividendo)	26,0 % / 26,0 %
Regla de múltiplos aplicada	v3: base a mitad de camino hacia la mediana adelantada, sin alejarse del actual más de ×1,1; bajista mín. 5 a (adelantado) o base × 0,80; alcista techo base × 1,35
Objetivo medio de los analistas (solo contraste)	480,60 (nuestro base -2,4 %)
Valor intrínseco (síntesis ponderada, largo plazo)	371,62 USD
Potencial sobre el precio actual	-2,0 %
Rentabilidad por dividendo ordinario	2,4 %
Rentabilidad total esperada a 12 meses	0,3 %
Escenario alcista / bajista	37,2 % / -35,3 %
Asimetría (ganancia alcista / pérdida bajista)	1,05x
Rentabilidad anual implícita en el precio frente al WACC y al que pide el mercado	9,4 % frente a 8,9 % y 8,0 %
Valor objetivo con la prima implícita del mercado (4,2 %, WACC 8,0 %)	435,72 USD
Rentabilidad total esperada con la prima del mercado	17,2 %
Asimetría con la prima del mercado	3,24x
Regla absoluta (frente a su coste de capital)	Mantener
Regla relativa (frente a lo que pide el mercado)	Comprar
Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2032e) frente al previsto para su mercado	3,2 % frente a 5,7 %

Elemento de la decisión	Valor
¿La calidad de la empresa sostiene el crecimiento previsto?	En parte (3,9 % anual proyectado; sin inversión neta)
Señal del valor intrínseco (regla del DCF, referencia)	Mantener
Recomendación según la regla a 12 meses (Comprar: ponderada ≥ 15 %, base ≥ 12 % y valor intrínseco ≥ precio; Vender: ponderada ≤ -10 %)	Mantener
Convicción según los criterios (las reglas discrepan (absoluta Mantener, relativa Comprar))	Baja

Regla (método v2): la recomendación sigue al objetivo a 12 meses, que es nuestro PER × nuestro BPA del ejercicio que mirará el mercado dentro de un año, con la misma regla de múltiplos para todas las empresas (base: el menor entre el PER actual y la mediana de 5 años; bajista: el mínimo de 5 años, o el base −15 % si ya cotiza por debajo; alcista: la media histórica o la de los comparables, sin pasar de base +30 %), ponderado con las probabilidades de los escenarios. Comprar si la rentabilidad ponderada es ≥ 15 %, la del base ≥ 12 % y el valor intrínseco no queda por debajo del precio; Vender si la ponderada es ≤ −10 %; Mantener en el resto. El consenso de analistas solo se compara. El valor intrínseco (DCF) es la referencia a largo plazo; su regla, la de siempre: Comprar si la rentabilidad total esperada a 12 meses es ≥ 15 % y el alcista gana al menos lo que pierde el bajista; Vender si es ≤ −10 %, o negativa con asimetría < 0,5; Mantener en el resto. Se aplica dos veces: con el WACC del análisis (regla absoluta: ¿rinde más que su coste de capital?) y con el WACC que resulta de la prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa: ¿rinde más que lo que hoy pide el mercado, ajustado por su beta?). Manda la relativa, salvo que las dos se contradigan (una Comprar y otra Vender): entonces, Mantener.

Acción	A qué precio
Comprar	Por debajo de 371,62 (ponderada a 12 meses ≥ 15 %, base ≥ 12 % y precio ≤ valor intrínseco)
Mantener	Entre 371,62 y 531,16
Vender o reducir	Por encima de 531,16 (ponderada a 12 meses ≤ -10 %)

Qué cambiaría la recomendación

- Si el precio cae por debajo de 362,33 USD sin cambio en las cifras, pasaríamos a Comprar.
- Si la guía de 2027 (enero) da un BPA ajustado por encima de 23 USD con el ratio de siniestralidad por debajo del 87 %, pasaríamos a Comprar.
- Si el ratio de siniestralidad del 3T26 o del 4T26 supera el 89 % o hay desarrollo desfavorable de reservas, pasaríamos a Vender.
- Si el DOJ presenta cargos penales o impone cambios en la codificación de riesgo de Medicare Advantage, pasaríamos a Vender.
- Si el precio supera 494,25 USD, venderíamos.

Dónde discrepamos del mercado

Lo que descuenta el precio.

Un margen EBITDA final del 7,5 % y un crecimiento del 3,2 % anual en 2027-2032: la recuperación de la guía de 2026 y algo más, pero no la vuelta a los márgenes previos a 2025. El consenso de analistas va más allá: 22 de 26 recomiendan comprar y el precio objetivo medio es de 480,60 USD [66, 67].

Lo que creemos nosotros.

Coincidimos con la recuperación (margen del 8,0 % en 2030) pero no con el precio objetivo de los analistas: con un coste de capital del 8,92 %, la recuperación esperada ya vale lo que cuesta. Los analistas llegan a 480 USD con primas de riesgo más bajas o con márgenes cercanos al 9 % de nuestro alcista.

Por qué podemos tener razón.

La beta de la acción (0,54) y la prima implícita del mercado (4,20 %) dan una tasa de descuento del 8,0 % que no recoge el riesgo regulatorio y legal específico de Medicare Advantage. Con ese riesgo, pedimos medio punto más; es la única diferencia con el mercado.

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	415,08	+9,4 %	45 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	275,37	-27,4 %	15 %
Transacciones precedentes (no se usa)	479,76	+26,5 %	0 %
Suma de partes	291,92	-23,0 %	15 %
Escenarios ponderados	398,95	+5,2 %	25 %

A favor

- **Recuperación ya en marcha**: guía de BPA ajustado de 2026 subida dos veces, de más de 17,75 a 19,50-20,00 USD [8].
- **Optum vale más de la mitad**: el 55 % del valor empresa de la suma de partes, con 154.726 M de ingresos en Optum Rx en 2025 [1].
- **Negocio sin capital**: capex del 0,8 % de las ventas y circulante negativo (−2,6 %); flujo operativo guiado de ≈ 24.000 M en 2026 [8].
- **ROIC por encima del coste de capital** aun en el peor año: 12,5 % frente a un WACC del 8,92 %.
- **Con la prima del mercado** el valor sube a 435,72 USD (+14,9 %).

En contra

- **El precio ya paga la recuperación**: rentabilidad total esperada del 0,3 % con nuestro coste de capital.
- **Riesgo legal abierto**: investigaciones penal y civil del DOJ sobre Medicare Advantage, sin cuantificar [30].
- **Pierde cuota**: del 29 % al 26 % de Medicare Advantage en un año [18].
- **Resultados con ayuda de reservas**: 1.250 M de desarrollo favorable en el 1S26 [5].
- **Gobierno debilitado**: presidente y CEO de 73 años, voto de remuneración del 60,0 % en 2025 [40].
- **Bajista profundo**: −35,3 % si el margen se queda en el 6,5 %.

Qué tiene que pasar para que la tesis funcione

La tesis depende de que el ratio de siniestralidad baje del 88-89 % de 2025 al 86-87 % por las subidas de primas, no por las reservas. La señal de que no se cumple: un ratio trimestral por encima del 88,5 % sin desarrollo favorable, o una guía de 2027 con un BPA ajustado por debajo de 21 USD. La segunda condición es regulatoria: el aviso de tarifas de Medicare Advantage de 2028 (finales de enero de 2027) por encima del +2 %.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Nivel actual	Umbral de alerta	Por qué importa
Ratio de siniestralidad (MCR)	86,7 % (2T26); guía 2026: 88,1 % ± 25 pb	> 88,5 % trimestral	Cada punto vale ≈ 13 % del valor.
Desarrollo de reservas de ejercicios anteriores	1.250 M favorables (1S26)	Desfavorable	Separa la mejora real de la contable.
Afiliados de Medicare Advantage	7,57 M (jun-26)	< 7,0 M en 2027	Mide la pérdida de cuota.
Resultado operativo de Optum Health	Guía 2026: > 2.275 M	< 2.000 M	Recuperación de la parte de servicios.
Aviso de tarifas de Medicare Advantage 2028	+2,48 % en 2027	< +2 %	CMS paga el 44 % de los ingresos del grupo [1].

Datos clave

EV/EBITDA últimos 12 m / próx. 12 m	**14,7x / 13,1x**	PER últimos 12 m / próx. 12 m	**24,4x / 18,4x**
EV/EBIT últimos 12 m	**17,3x**		
EV/Ventas últimos 12 m	**0,94x**	Rentabilidad por FCF	**6,9 %**
Rentabilidad por dividendo	**2,4 %**	Crecimiento anual de ingresos (2016-2025)	**10,3 %**
Margen EBITDA últimos 12 m	**6,4 %**	ROIC último ejercicio	**12,5 %**
WACC	**8,9 %**	Deuda neta / EBITDA (contable · ajustada)	**2,5x · 2,7x**
Gobierno (criterios cumplidos)	**11 de 13**		

Parte I — Negocio y sector

1. Historia e hitos

Confianza: Media

UnitedHealth nace de Charter Med, fundada en Minnesota por Richard Taylor Burke; en 1977 se crea United HealthCare Corporation para comprarla, sale a bolsa en 1984 y adopta el nombre de UnitedHealth Group en 1998 [33]. Crece por adquisiciones en seguro (PacifiCare, 2005) y, desde 2011, construye Optum: servicios de salud, datos y farmacia. Las grandes compras de la última década son Catamaran (2015, 14.300 M USD en efectivo con su deuda), DaVita Medical Group (2019, 4.300 M), Change Healthcare (octubre de 2022) y Amedisys (cerrada el 14-ago-2025) [2, 11, 33, 36]. En 2024 vende Brasil y sufre el ciberataque de Change Healthcare; en 2025 el beneficio operativo cae un 41 % por el coste médico y los recortes de Medicare Advantage, Andrew Witty deja la empresa y Stephen Hemsley vuelve como consejero delegado en mayo de 2025 [1, 31, 32].

Año	Hito
1977	Se crea United HealthCare Corporation para comprar Charter Med, fundada por Richard Taylor Burke [33].
1984	Salida a bolsa [33].
1998	Cambio de nombre a UnitedHealth Group y reorganización en negocios independientes [33].
2005	Compra de PacifiCare Health Systems, que refuerza Medicare en el oeste de EE. UU. [33].
2011	Nace la marca Optum, que agrupa servicios de salud, tecnología y farmacia [33].
2015	Optum Rx compra Catamaran (23-jul-2015) por 14.300 M USD en efectivo, incluida la amortización de su deuda [36].
2019	Optum compra DaVita Medical Group por 4.300 M USD, base de la atención primaria de Optum Health [33].
2022	Cierre de la compra de Change Healthcare (octubre), cámara de compensación de reclamaciones que pasa a Optum Insight [33].
2024	Ciberataque a Change Healthcare (21-feb): unos 190 M de personas afectadas y 2.200 M USD de costes directos en el año; venta de Brasil (Amil) con pérdida contable de 8.310 M por ventas de filiales [1, 2].
2025	Salida de Andrew Witty y vuelta de Stephen Hemsley como consejero delegado (mayo); el DOJ abre investigaciones penal y civil sobre Medicare Advantage (julio); cierre de Amedisys (agosto); MCR del 89,1 % y beneficio operativo de 18.964 M (−41 %) [1, 11, 30, 31, 32].
2026	CMS fija la subida de tarifas de Medicare Advantage para 2027 en el 2,48 % tras proponer un 0,09 % en enero; UnitedHealth recorta 785.000 afiliados de Medicare Advantage en un año para recuperar margen [5, 25, 26].

2. Modelo de negocio

Confianza: Alta

UnitedHealth es el mayor grupo de salud de EE. UU. por ingresos (447.567 M USD en 2025) y tiene dos negocios [1]. **UnitedHealthcare** asegura a 49,8 M de personas (dic-2025): seguro de empresa e individual (29,7 M, de ellos 21,5 M en contratos de solo administración), Medicare Advantage (8,4 M), Medicaid gestionado (7,4 M) y Medicare Supplement (4,3 M), además de 2,8 M en planes de farmacia Part D independientes [1]. **Optum** tiene tres segmentos: Optum Health (médicos propios y atención basada en valor, cirugía, atención domiciliaria; 101.957 M de ingresos), Optum Insight (datos, software, gestión de ciclo de ingresos y la cámara de compensación de Change Healthcare; 19.417 M y una cartera de pedidos de 31.100 M) y Optum Rx (gestor de beneficios de farmacia con unas 64.000 farmacias en red y 188.000 M de gasto en fármacos gestionado; 154.726 M) [1]. Tiene más de 390.000 empleados, unos 165.000 de ellos clínicos [1].

Cómo gana dinero

Casi el 80 % de los ingresos son primas de productos con riesgo: la empresa cobra una cuota mensual fija por afiliado, normalmente por un año, y paga los siniestros [1]. El margen depende del ratio de siniestralidad (MCR: 89,1 % en 2025 frente al 85,5 % de 2024) y del ratio de costes operativos (13,3 %) [1]. Un punto de MCR sobre 352.229 M de primas

son unos 3.500 M de beneficio operativo (estimación propia). Las primas se fijan con un año de antelación (Medicare Advantage con las tarifas de CMS de abril y las pujas de junio), así que un repunte imprevisto de la utilización no se recupera hasta el ejercicio siguiente [1, 5]. Optum cobra comisiones y precios de servicio, en buena parte a UnitedHealthcare: las eliminaciones entre segmentos fueron 173.436 M en 2025 [1]. Optum Rx gana con márgenes estrechos (4,6 %) sobre un volumen muy alto; Optum Insight es el negocio de más margen (13,5 %) [1]. Los ingresos por inversiones de las reservas sumaron 3.920 M en 2025 [1].

Segmentos (2025)

Segmento	Ingresos	% del total	Crecimiento	Margen	Tipo de margen
UnitedHealthcare	344.903	77,1 %	+15,7 %	2,7 %	EBIT
Optum Health	101.957	22,8 %	-3,2 %	-0,3 %	EBIT
Optum Insight	19.417	4,3 %	+3,5 %	13,5 %	EBIT
Optum Rx	154.726	34,6 %	+16,1 %	4,6 %	EBIT
Eliminaciones	-173.436	-38,8 %	+11,7 %	0,0 %	EBIT



Ingresos por segmento	2021	2022	2023	2024	2025
UnitedHealthcare	222.899	249.741	281.360	298.208	344.903
Optum Health	54.065	71.174	95.319	105.358	101.957
Optum Insight	12.199	14.581	18.932	18.757	19.417
Optum Rx	91.314	99.773	116.087	133.231	154.726
Eliminaciones	-92.880	-111.107	-140.076	-155.276	-173.436



Clientes, recurrencia y poder de precios

El primer cliente es el Estado federal: las primas de CMS (Medicare) fueron el 44 % de los ingresos consolidados en 2025, frente al 40 % en 2024 y 2023 [1]. Los contratos con riesgo se renuevan cada año, y en Medicare Advantage el precio lo marca la tarifa de CMS: la empresa ajusta prestaciones y condados en cada puja [5]. En 2026 ha elegido margen frente a volumen: los afiliados de Medicare Advantage bajaron de 8,35 M a 7,57 M (−9 %) entre junio de 2025 y junio de 2026, los de comercial con riesgo un 9 % y los de Medicaid un 9 % (salida de un estado) [5]. En comercial crece el negocio sin riesgo (21,5 M de afiliados en contratos de administración frente a 8,2 M con riesgo) [1]. Además, se ha comprometido a devolver a los clientes el beneficio de 2026 del seguro individual del ACA [5].

Indicadores operativos

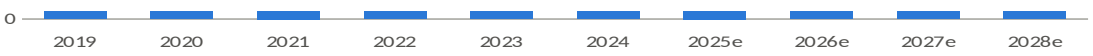
Indicador	Anterior	Actual	Variación	Lectura
Personas atendidas por UnitedHealthcare (médico, miles)	49.345 (2024)	49.760 (2025); 48.525 (jun-26)	+415 en 2025; −1.590 interanual en jun-26	Crece el comercial autofinanciado y cae el asegurado [1, 5].
Medicare Advantage (miles)	7.845 (2024)	8.445 (2025); 7.565 (jun-26)	+600 en 2025; −785 interanual en jun-26	Salida de mercados y nuevas prestaciones para 2026 [1, 5].
Medicaid (miles)	7.435 (2024)	7.380 (2025); 6.780 (jun-26)	−55; −710 interanual	Revisiones de elegibilidad y salida de Luisiana [1, 5, 8].
Comercial: con riesgo / autofinanciado (miles)	8.845 / 20.885 (2024)	8.165 / 21.485 (2025); 7.655 / 22.265 (jun-26)	−680 / +600	Mezcla hacia servicios sin riesgo [1, 5].
Ratio de siniestralidad (MCR)	85,5 % (2024)	89,1 % (2025); 85,3 % (1S26)	+360 pb; −180 pb interanual en 1S26	Guía 2026: 88,1 % ± 25 pb [1, 5, 8].
Personas atendidas por Optum Health (millones)	100 (2024)	95 (2025); 93 (jun-26)	−5	Unos 700.000 pacientes menos en asistencia basada en valor en el 2T26 [1, 5, 8].
Recetas ajustadas de Optum Rx (millones)	1.623 (2024)	1.659 (2025)	+2 %	387 millones en el 2T26 frente a 414 en el 2T25 [1, 8].
Cartera de pedidos de Optum Insight (M USD)	32.800 (2024)	31.100 (2025)	−5 %	18.300 M a realizar en 12 meses; 12.900 M con empresas del grupo [1].

3. Sector y mercado

Confianza: Alta

El mercado relevante es el gasto sanitario de EE. UU., donde UnitedHealth cobra primas y servicios: las cuentas nacionales de salud de CMS (National Health Expenditures) lo miden en 5,28 billones de USD en 2024 [15]. Dentro de él, los subsectores de UnitedHealth son el seguro privado (1,64 billones en 2024), Medicare (1,12 billones, del que Medicare Advantage cubre al 55 % de los beneficiarios elegibles en 2026) y Medicaid (0,93 billones), además de los fármacos de receta (467.000 M) que intermedian los gestores de farmacia [15, 18]. Se usa la serie oficial de la Oficina del Actuario de CMS [17]; la segunda fuente, la propia UnitedHealth, sitúa el gasto sanitario en el 19 % del PIB en 2025 [1], frente al 18,0 % de 2024 de CMS [15].

Tamaño del mercado	**5,28 billones de USD en 2024 (18,0 % del PIB) y 5,66 billones estimados en 2025; CMS proyecta 9,0 billones en 2034 [15, 16, 17].**	Posición en el ciclo	**Recuperación**
Crecimiento histórico anual	**6,8 %**	Crecimiento previsto anual	**5,7 %**
Cuota de los 5 primeros	**57 %**	Estructura	**Concentrada**



Motores de la demanda

Motor	Efecto	Horizonte	Evidencia
Envejecimiento y paso a Medicare	+	Estructural	La población de 65 años o más crece un 2,8 % en 2025 y un 2,7 % en 2026; CMS prevé que el gasto de Medicare crezca un 7,7 % anual en 2025-34, frente al 5,0 % del seguro privado [16, 17].
Penetración de Medicare Advantage	+	Estructural	El 55 % de los beneficiarios elegibles (35,2 M) está en Medicare Advantage en 2026, frente al 19 % en 2007; la CBO prevé el 63 % en 2034, aunque el crecimiento se frena (+3 % en 2026) [18].
Utilización y coste médico	–	Cíclico	En 2025 subió el ratio de siniestralidad de todo el sector: UnitedHealth del 85,5 % al 89,1 %, Elevance del 88,5 % al 90,0 %, Centene del 88,3 % al 91,9 % y Molina del 89,1 % al 91,7 % [1, 19, 23, 24]. CMS prevé que el gasto se modere del 7,3 % en 2025 al 6,3 % en 2026 por menor utilización [16].
Tarifas de Medicare Advantage y ajuste por riesgo	+/–	Cíclico	Subida de pagos del 5,06 % en 2026 y del 2,48 % en 2027 (4,98 % con la tendencia de puntuaciones de riesgo); la revisión del modelo de riesgo resta un 1,12 % en 2027 y la exclusión de diagnósticos de revisiones de historias no vinculadas, un 1,53 % [25, 27].
Recortes de Medicaid y fin de los subsidios reforzados del ACA	–	Estructural	CMS prevé 3,7 M menos de asegurados en compra directa en 2026 por el fin de los subsidios reforzados y 2,6 M menos en Medicaid en 2027-28 por los requisitos de la ley OBBBA; el seguro de la población baja del 91,8 % en 2024 al 90,4 % en 2028 [16].
Fármacos de especialidad y GLP-1	+/–	Estructural	El gasto en fármacos de receta crece un 11,1 % en 2025 (518.700 M) por diabetes y obesidad [16]; más volumen para los gestores de farmacia y más coste para las aseguradoras. Optum Rx gestionó 87.000 M en especialidad en 2025 [1].

Las cinco fuerzas

Amenaza de entrada

Poder de los proveedores

Fuerza	Intensidad (1-5)	Justificación
Rivalidad	4	Los afiliados cambian de aseguradora cada año: en Medicare Advantage Humana ganó 1,3 M de afiliados en 2026 y UnitedHealth perdió 647.000 [18]. Los márgenes operativos de 2025 fueron bajos: del −3,9 % de Centene al 4,2 % de UnitedHealth [1, 19, 20, 21, 22, 23, 24].
Poder de los clientes	4	El Estado fija el precio en Medicare y Medicaid: CMS propuso una subida de solo el 0,09 % para 2027 y es el 44 % de los ingresos de UnitedHealth [1, 26]. Las grandes empresas se autoaseguran: 21,5 M de los 29,7 M de afiliados comerciales de UnitedHealth están en contratos de solo administración [1].
Poder de los proveedores	4	El gasto hospitalario creció un 8,9 % en 2024 [15]. UnitedHealth atribuye el coste comercial elevado a precios de los proveedores, servicios agrupados por visita y al arbitraje de la ley No Surprises [5]. Los laboratorios fijan el precio de los fármacos de especialidad.
Amenaza de entrada	2	Hacen falta capital regulado, redes de proveedores y escala: los cinco mayores tienen el 57 % del seguro comercial y en el 97 % de las áreas metropolitanas el mercado está muy concentrado [29]. Hay entrantes en Medicare Advantage: Devoted Health ganó 258.000 afiliados en 2026 [18].
Amenaza de sustitutos	2	El sustituto de Medicare Advantage es Medicare tradicional (el 45 % de los elegibles sigue en él) [18]; el del seguro con riesgo, el autoaseguramiento de la empresa, que UnitedHealth también administra [1].

Ciclo

El sector viene de un ciclo de siniestralidad alta: en 2025 el ratio de siniestralidad subió entre 1,5 y 3,6 puntos en las grandes aseguradoras y Centene registró un deterioro de 6.700 M [1, 19, 23, 24]. En 2026 las primas se han subido y se han recortado prestaciones y afiliados: el MCR de UnitedHealth bajó al 86,7 % en el 2T26 con 860 M de desarrollo favorable de ejercicios anteriores [5, 8]. En 2020 la utilización se hundió (el gasto del seguro privado creció solo un 0,4 %) y repuntó en 2023 (+11,2 %) [17]. La serie de CMS no cubre 2008-09.

Regulación

Medicare Advantage: CMS subió los pagos un 5,06 % para 2026 (más de 25.000 M) y, tras proponer un 0,09 % el 26-ene-2026, fijó un 2,48 % para 2027 el 6-abr-2026 (más de 13.000 M; 4,98 % con la tendencia de riesgo); renunció al nuevo modelo de riesgo de 2027 y mantiene el de 2024 (V28), pero excluye diagnósticos de revisiones de historias no vinculadas [25, 26, 27]. Farmacia: la ley de presupuestos firmada a principios de febrero de 2026 desvincula la remuneración de los gestores de farmacia del precio de los fármacos en Part D y obliga a trasladar los descuentos [34]. ACA: expiraron los subsidios reforzados (−3,7 M asegurados en 2026) [16]. Medicaid: la ley OBBBA limita impuestos a proveedores y pagos dirigidos y exige requisitos de trabajo [16].

Tendencias y disrupción

Tres tendencias pesan en las cifras. Primera, la integración vertical: aseguradora, gestor de farmacia y médicos propios en un mismo grupo (UnitedHealth con Optum, CVS con Aetna y Caremark, Cigna con Express Scripts); es la base del modelo de UnitedHealth, pero atrae la regulación de los gestores de farmacia [34]. Segunda, el paso de pago por acto a atención basada en valor, que en 2025 dio pérdidas a Optum Health (−278 M) por la reducción de las tarifas de Medicare [1]. Tercera, la caída de la cuota de los grandes en Medicare Advantage frente a Humana, Kaiser y aseguradoras nuevas (Devoted, SCAN) [18]. La inteligencia artificial y la regulación de datos aparecen como riesgo y oportunidad en el 10-K [1].

4. Posición competitiva y foso

Confianza: Media

Cuota de mercado	**26,0 %**	Posición	**1.º en Medicare Advantage en EE. UU. (26 % de los afiliados en 2026, 9,3 M; 29 % en 2025) [18]. También 1.º en seguro comercial (16 % nacional en 2024) [29] y 3.º gestor de farmacia con Optum Rx (≈23 % de las recetas equivalentes de 2025; estimación propia: 1.659 M de recetas sobre un mercado de ≈7.220 M, deducido de que los tres mayores procesan el 80 %) [28]. Sus ingresos de 2025 equivalen al 7,9 % del gasto sanitario nacional estimado (estimación propia) [1, 17].**
Foso	**Estrecho**	Tendencia del foso	**Se estrecha**

Competidor	País	Cotiza	Ingresos (M)	Cuota	M. EBIT	Cómo compite
CVS Health (Aetna, CVS Caremark)	EE. UU.	CVS	402.067	12,0 %	1,2 %	Modelo integrado como UnitedHealth: aseguradora (26,6 M de afiliados médicos, MBR del 91,2 %), Caremark (1.900,7 M de recetas) y farmacias. Beneficio operativo de 4.660 M en 2025. Cuota en Medicare Advantage [18, 21].
The Cigna Group (Express Scripts, Evernorth)	EE. UU.	CI	274.900	–	3,3 %	Líder en gestión de farmacia: Express Scripts procesó 2.220 M de recetas en 2025 (≈31 % del mercado, estimación propia) [28]. Vendió Medicare Advantage a HCSC; 18,1 M de clientes médicos y MCR del 84,4 % en Cigna Healthcare [20].
Elevance Health	EE. UU.	ELV	199.125	5,0 %	4,1 %	2.° en seguro comercial (12 %), con marcas Blue Cross Blue Shield; 45,2 M de afiliados médicos y ratio de prestaciones del 90,0 % en 2025. Margen calculado como beneficio antes de impuestos más intereses (8.112 M) [19, 29].
Centene	EE. UU.	CNC	194.777	–	-3,9 %	Líder en Medicaid gestionado y en el seguro individual del ACA; 27,6 M de afiliados y HBR del 91,9 %. Pérdida operativa de 7.623 M en 2025 por un deterioro de fondo de comercio de 6.700 M [23].
Humana	EE. UU.	HUM	129.664	20,0 %	2,1 %	2.° en Medicare Advantage y el que más crece (+1,3 M de afiliados en 2026) [18]. Ratio de prestaciones del 90,2 % y 15,0 M de afiliados médicos en 2025; CenterWell (atención primaria y domiciliaria) compite con Optum Health [22].
Molina Healthcare	EE. UU.	MOH	45.426	–	1,7 %	Medicaid, Medicare y ACA; 5,5 M de afiliados y MCR del 91,7 % en 2025 (89,1 % en 2024); compite con Community & State en concursos estatales [24].



Fuentes de ventaja competitiva



Fuente	Puntuación (0-5)	Evidencia
Efectos de red	2	Change Healthcare conecta a pagadores y proveedores en la tramitación de reclamaciones, y la red de Optum Rx tiene unas 64.000 farmacias [1]; pero el afiliado no gana valor porque haya más afiliados.
Costes de cambio	3	Los contratos de Optum Insight duran varios años (cartera de 31.100 M) [1]; en cambio, los contratos de seguro se renuevan cada año y UnitedHealth perdió 647.000 afiliados de Medicare Advantage en 2026 [6].
Intangibles (marca, patentes, licencias)	2	Licencias de aseguradora en todos los estados y contratos con CMS; la marca ha sufrido con el ciberataque, la investigación del DOJ y la polémica por las denegaciones [1, 19].
Ventaja en costes	3	Margen operativo del 8,1-8,7 % en 2023-24 y del 4,2 % en 2025, el más alto de las seis comparables en 2025 [1, 7-12]; su ratio de costes operativos (13,3 %) no es menor que el de Humana (12,0 %) ni el de Elevance (10,6 %) porque incluye los servicios de Optum [1, 7, 10].
Escala eficiente	4	1.° en Medicare Advantage (26 %) y en seguro comercial (16 %), 49,8 M de afiliados médicos y 188.000 M de gasto en fármacos gestionado: escala para negociar con hospitales y laboratorios y repartir el coste de los datos [1, 6, 17].

Amenazas

La amenaza más cercana es regulatoria: la revisión del ajuste por riesgo de Medicare Advantage (−1,12 % por el modelo y −1,53 % por las fuentes de diagnósticos en 2027) recorta justo los ingresos donde UnitedHealth es líder [25], y las investigaciones penal y civil del DOJ sobre su participación en Medicare siguen abiertas [30]. La ley de presupuestos de 2026 desvincula la remuneración de los gestores de farmacia del precio de los fármacos en Part D [34], y la integración de aseguradora y médicos propios (Optum Health) está en el punto de mira. En el mercado, Humana y aseguradoras nuevas ganan cuota en Medicare Advantage mientras UnitedHealth la cede al subir precios (del 29 % al 26 %) [18].

Parte II — Finanzas

5. Cuenta de resultados

Confianza: Alta

Periodo	Ingresos	Crec.	M. bruto	EBITDA	M. EBITDA	EBIT	M. EBIT	B. neto	BPA	DPA	Tipo imp.
2016	184.840	–	23,5 %	14.985	8,1 %	12.930	7,0 %	7.017	7,25	2,38	40 %
2017	201.159	+8,8 %	23,4 %	17.454	8,7 %	15.209	7,6 %	10.558	10,72	2,88	23 %
2018	226.247	+12,5 %	23,8 %	19.772	8,7 %	17.344	7,7 %	11.986	12,19	3,45	22 %
2019	242.155	+7,0 %	23,8 %	22.405	9,3 %	19.685	8,1 %	13.839	14,33	4,14	21 %
2020	257.141	+6,2 %	26,1 %	25.296	9,8 %	22.405	8,7 %	15.403	16,03	4,83	24 %
2021	287.597	+11,8 %	24,2 %	27.073	9,4 %	23.970	8,3 %	17.285	18,08	5,60	21 %
2022	324.162	+12,7 %	24,6 %	31.835	9,8 %	28.435	8,8 %	20.120	21,18	6,40	22 %
2023	371.622	+14,6 %	24,5 %	36.330	9,8 %	32.358	8,7 %	22.381	23,86	7,29	21 %
2024	400.278	+7,7 %	22,3 %	36.386	9,1 %	32.287	8,1 %	14.405	15,51	8,18	24 %
2025	447.567	+11,8 %	18,5 %	26.077	5,8 %	21.716	4,9 %	12.056	13,23	8,73	13 %

Crecimiento anual compuesto 2016-2025: ingresos **10,3 %**, EBITDA **6,3 %**, BPA **6,9 %**.



Los ingresos pasaron de 184.840 M en 2016 a 447.567 M en 2025 (TCAC del 10,3 %), con compras cada año (de 1.760 M en 2016 a 21.458 M en 2022) [1, 2, 3, 4, 12]. El beneficio operativo creció hasta 32.358 M en 2023 (margen del 8,7 %) y cayó a 18.964 M en 2025 (4,2 %): el ratio de siniestralidad (MCR) subió de 83,2 % en 2023 a 85,5 % en 2024 y 89,1 % en 2025 por los recortes de financiación de Medicare Advantage, el efecto de la IRA en la Parte D, una tendencia de costes médicos elevada y menos desarrollo favorable de reservas (140 M en 2025 frente a 700 M en 2024) [1]. El ratio de costes operativos bajó de 15,4 % (2016) a 13,3 % (2025), en parte por la mezcla (Optum Rx y primas crecen más que los servicios) [1, 4]. Años no comparables: 2024 (pérdida por la venta de Brasil de 8.310 M por debajo del resultado operativo y efectos del ciberataque a Change Healthcare) y 2025 (cargo del 4T de 2.878 M antes de impuestos) [1, 10]. En el LTM a junio de 2026 el beneficio operativo vuelve a 21.676 M con un MCR del 85,3 % en el semestre [5].

Ajustes y partidas no recurrentes

Las cifras son las publicadas. El BPA ajustado de UNH excluye siempre la amortización de intangibles (1.700 M en 2025; unos 1.345 M previstos para 2026), que es recurrente, y además partidas puntuales [1, 8]. En 2025 el BPA ajustado fue 16,35 USD frente a 13,23 publicado; el cargo del 4T25 restó 2.878 M antes de impuestos (ciberataque 799 M, reestructuración y otros 2.521 M, desinversiones netas +442 M) y 1,78 USD por acción [10]. Dentro del resultado operativo quedaron 2.752 M (799 + 2.521 − 568 de ganancias de cartera en costes operativos), que se marcan como no recurrentes en 2025; el resultado operativo ajustado de la empresa fue 21.700 M [10]. En el LTM se netean además 153 M de reestructuración y −191 M de desinversiones del primer semestre de 2026 (2.714 M) [8]. En 2024 no se ajusta: los costes del ciberataque (unos 2.100 M de diferencia entre el resultado operativo ajustado de 34.400 M y el publicado de 32.287 M) quedan compensados por 3.300 M de ganancias por refinamiento de cartera registradas en costes operativos [1, 10]. Las pérdidas por ventas de filiales (8.310 M en 2024, 265 M en 2025) están por debajo del resultado operativo y van en el resultado financiero.

6. Resultados recientes

Confianza: Media

Periodo	Ingresos	Crec. interanual	EBITDA	M. EBITDA	BPA	Frente al consenso
3T24	100.820	+9,2 %	9.749	9,7 %	6,51	–
4T24	100.807	+6,8 %	8.814	8,7 %	5,99	–
1T25	109.575	+9,8 %	10.180	9,3 %	6,85	–
2T25	111.616	+12,9 %	6.234	5,6 %	3,74	–
3T25	113.161	+12,2 %	5.414	4,8 %	2,59	–
4T25	113.215	+12,3 %	1.497	1,3 %	0,01	–
1T26	111.721	+2,0 %	10.019	9,0 %	6,90	Superior
2T26	112.032	+0,4 %	9.031	8,1 %	6,04	–



Lo que dijo la dirección en las últimas presentaciones

En la conferencia del 2T26 (16-jul-2026) la dirección (Stephen Hemsley, consejero delegado; Wayne DeVeydt, director financiero) atribuyó la mejora a Medicare Advantage y a Optum Health, y elevó la guía a un BPA ajustado de 19,50-20,00 USD [8, 13]. Mensajes: la tendencia de costes de Medicare de 2026 quedará por debajo del ~10 % presupuestado (con 7,5 % de base de 2025), ayudada por una temporada respiratoria suave y por desarrollo de reservas de ejercicios anteriores; en el negocio comercial la tendencia es «modestamente superior al 11 %» por el arbitraje (IDR) de la ley No Surprises y la mayor intensidad de facturación, y la recuperación del margen comercial se alarga más allá de 2027; los márgenes de Medicaid seguirán entre −1 % y −1,7 % en 2026; Medicare Advantage perderá unos 1,1 millones de afiliados en el año y su margen superará el 3 % [13]. Los analistas preguntaron sobre todo por la tendencia de costes (comercial, Medicare), por si 19,50-20,00 USD es una base limpia para el crecimiento del 13-16 % (DeVeydt: no hay nada que descontar) y por cuánto del gasto en inversión del trimestre es puntual [13]. Frente al 1T26 (21-abr-2026), cuando la guía ajustada subió a más de 18,25 USD y se anunció la compra de Alegeus, el discurso pasa de la reestructuración a defender la base de 2026 y el crecimiento de 2027 [9, 13].

7. Balance y capital circulante

Periodo	Activo total	Fondo com. + intang.	Circulante	Caja	Deuda fin.	Arrend.	Deuda neta	Patrimonio	DN/ EBITDA
2016	122.810	56.125	-5.209	13.275	32.970	0	19.695	38.274	1,3x
2017	139.058	63.045	-5.612	15.490	31.692	0	16.202	47.776	0,9x
2018	152.221	68.235	-5.317	14.324	36.554	0	22.230	51.696	1,1x
2019	173.889	76.008	-7.183	14.245	40.678	0	26.433	57.616	1,2x
2020	197.289	82.193	-9.625	19.781	43.467	0	23.686	65.491	0,9x
2021	212.206	85.839	-7.527	23.907	46.003	0	22.096	71.760	0,8x
2022	245.705	107.753	-6.534	27.911	57.623	0	29.712	77.772	0,9x
2023	273.720	118.926	-7.882	29.628	62.537	0	32.909	88.756	0,9x
2024	298.278	130.002	-8.172	29.113	76.904	0	47.791	92.658	1,3x
2025	309.581	130.973	-11.714	28.121	78.389	0	50.268	94.110	1,9x

Periodo	Circulante / ventas	Días de cobro	Días de inventario	Días de pago	Ciclo de caja (días)	Liquidez corriente
2016	-2,8 %	16	–	34	–	0,7x
2017	-2,8 %	17	–	36	–	0,7x
2018	-2,4 %	18	–	35	–	0,7x
2019	-3,0 %	18	–	38	–	0,7x
2020	-3,7 %	18	–	43	–	0,7x
2021	-2,6 %	18	5	41	-18	0,8x
2022	-2,0 %	20	5	41	-16	0,8x
2023	-2,1 %	21	4	42	-17	0,8x
2024	-2,0 %	20	4	40	-16	0,8x
2025	-2,6 %	19	3	38	-16	0,8x

Días de inventario y de pago calculados sobre el coste de ventas.

Cambio de perímetro (2022: Change Healthcare y otras compras: 21.458 M pagados en efectivo en el año (frente a 4.821 M en 2021); el fondo de comercio pasa de 75.795 M a 93.352 M.; 2024: Venta de las operaciones de Brasil (6-feb-2024): pérdida de 7.100 M, 4.100 M de ella por diferencias de conversión acumuladas; sale del perímetro casi todo UnitedHealthcare Global.; 2025: Desconsolidación de un negocio de Optum Rx por cambio en los derechos de gobierno (ganancia de 1.700 M en costes operativos) y salidas y ventas de negocios de Optum Health clasificados como mantenidos para la venta.). Los ratios de balance de ese año (días, circulante, deuda neta / EBITDA, ROIC) y los indicadores de calidad contable no son comparables con los anteriores.

La deuda financiera (papel comercial + bonos, valor contable) pasó de 32.970 M en 2016 a 78.389 M en 2025, con los saltos de 2022 (Change Healthcare) y 2024 (préstamos sin interés a proveedores tras el ciberataque y compras) [1, 2, 3, 4]. A 30-jun-2026 baja a 73.328 M (3.827 M a corto y 69.501 M a largo) tras amortizar 2.500 M de bonos y 2.313 M de papel comercial, y la ratio deuda/capital cae al 41,2 % desde el 43,9 % de cierre de 2025, con objetivo del ~40 % a final de 2026 [5, 8]. La nota de deuda da un total de 77.681 M en 2025 (76.180 M en 2024), algo menos que la suma del balance. El circulante es estructuralmente negativo (114.897 M de pasivo corriente frente a 90.582 M de activo): el flotante de reservas médicas y primas cobradas por anticipado financia el activo. Fondo de comercio e intangibles suman 130.973 M, el 42 % del activo [1].

8. Flujos de caja

Confianza: Alta

Periodo	Flujo operativo	Capex	Arrend.	FCF	B. neto	FCF / B. neto	Capex / ventas	Capex / amort.	FCF por acción
2016	9.795	1.705	0	8.090	7.017	115 %	0,9 %	0,8x	8,36
2017	13.596	2.023	0	11.573	10.558	110 %	1,0 %	0,9x	11,75
2018	15.713	2.063	0	13.650	11.986	114 %	0,9 %	0,8x	13,89
2019	18.463	2.071	0	16.392	13.839	118 %	0,9 %	0,8x	16,97
2020	22.174	2.051	0	20.123	15.403	131 %	0,8 %	0,7x	20,94
2021	22.343	2.454	0	19.889	17.285	115 %	0,9 %	0,8x	20,80
2022	26.206	2.802	0	23.404	20.120	116 %	0,9 %	0,8x	24,64
2023	29.068	3.386	0	25.682	22.381	115 %	0,9 %	0,8x	27,38
2024	24.204	3.499	0	20.705	14.405	144 %	0,9 %	0,8x	22,29
2025	19.697	3.622	0	16.075	12.056	133 %	0,8 %	0,8x	17,65



Acumulado 2016-2025: FCF **175.583**, conversión **121 %** del beneficio neto; adquisiciones 79.702, dividendos 50.351, recompras 51.575.

El flujo operativo ha superado al beneficio neto todos los años (19.697 M frente a 12.056 M en 2025, 1,5 veces), porque el negocio asegurador cobra primas por anticipado y paga los siniestros con decalaje, y la amortización (4.361 M) supera al capex (3.622 M) [1, 10]. Años anómalos: 2024 (24.204 M) por las ayudas a proveedores tras el ciberataque a Change Healthcare (9.033 M de préstamos sin interés, de los que se devolvieron 4.514 M en 2024, 1.680 M en 2025 y 197 M en el 1S26), y 2025, apoyado en la venta de cuentas a cobrar y en cobros adelantados que la empresa esperaba para 2026 [1, 5, 10]. En el 1S26 el flujo operativo fue de 19.964 M por el calendario de un pago público importante; la guía de 2026 es de ~24.000 M [5, 8]. La empresa no separa el capex de mantenimiento y el de crecimiento; casi todo es software capitalizado y equipos (Optum Insight 1.170 M y Optum Health 1.237 M en 2025) [1]. Los intereses pagados (4.030 M en 2025) están en el flujo operativo [12].

9. Calidad contable

Confianza: Alta

Auditor	**Deloitte & Touche LLP (Minneapolis)**	Años como auditor	**24**
Opinión del último informe	**Favorable**	Ejercicio analizado	**2025**

Indicador	Valor	Lectura
Altman Z	3,00	Zona segura (> 2,99 seguro; < 1,81 riesgo). No aplica a bancos ni aseguradoras, y subestima la solvencia de empresas con grandes anticipos de clientes o prefinanciación pública (contratistas, construcción), que inflan el pasivo. No fiable en 2025: cambio de perímetro (el balance incluye negocios sin su cuenta de resultados completa).
Piotroski F	6 / 9	Intermedio (4-6).
Beneish M	-2,47	No interpretable en 2025: con un cambio de perímetro, los índices de activos, amortización y ventas (AQI, DEPI, SGI) comparan grupos distintos y el umbral de −1,78 no sirve.
Flujo operativo / beneficio neto (acumulado)	1,39x	El beneficio se cobra.

Criterio Piotroski	Cumple
Beneficio neto positivo	Sí
Flujo operativo positivo	Sí
ROA mejora	No
Flujo operativo > beneficio neto	Sí
Baja el endeudamiento (deuda / activo)	Sí
Mejora la liquidez corriente	No
No emite acciones	Sí
Mejora el margen bruto	No
Mejora la rotación del activo	Sí

Ajustes, criterios contables y remuneración en acciones

Deloitte audita a la compañía desde 2002 y su informe sobre 2025 (2-mar-2026) es favorable; la única cuestión clave de auditoría es la estimación de los siniestros incurridos y no comunicados (IBNR), que depende de factores de completitud y de tendencia de coste por miembro y mes [1]. El juicio contable más sensible es por tanto la reserva: el desarrollo favorable de ejercicios anteriores cayó de 1.720 M en 2021 y 840 M en 2023 a 140 M en 2025 (con un 4T25 implícitamente desfavorable), y vuelve a 1.250 M en el 1S26 [1, 3, 5]. Las ganancias y pérdidas por ventas y desconsolidaciones de negocios se registran dentro de los costes operativos (3.300 M de ganancias en 2024; 1.700 M por una desconsolidación en 2025), lo que mueve el margen operativo sin ser explotación [1, 2]. El BPA ajustado excluye la amortización de intangibles (~1.700 M al año) [1, 8]. La remuneración en acciones fue de 971 M en 2025 (8 % del beneficio neto) [12]. El tipo fiscal bajó al 12,9 % en 2025 por el menor beneficio y las desinversiones [1]. Sin deterioros de fondo de comercio en diez años [12].

Señales de alerta

Señal	Nivel	Explicación
Caída del desarrollo favorable de reservas	Media	De 700 M (2024) a 140 M (2025), con −260 M implícitos en el 4T25; en 2026 el desarrollo favorable vuelve a ser alto (1.250 M en el semestre) y ayuda al MCR [1, 5, 11].
Resultados de cartera dentro de los costes operativos	Media	3.300 M de ganancias en 2024 y 568 M netos en 2025 (con 1.700 M por desconsolidación en Optum Rx) dentro del resultado operativo [1, 2].
Ajustes no GAAP recurrentes	Media	El BPA ajustado excluye cada año la amortización de intangibles (1,50 USD por acción previstos en 2026) y cargos que se repiten (ciberataque 2024-2025, reestructuración 2025) [8, 10].
Flujo operativo apoyado en venta de cuentas a cobrar y adelantos	Media	La empresa cita la venta de cuentas a cobrar y cobros adelantados de 2026 en el flujo de 2025, y el calendario de un pago público en el 1S26 [1, 5, 10].
Provisiones sobre préstamos del ciberataque	Baja	799 M de provisión en el 4T25 por la cobrabilidad de préstamos a proveedores y otros saldos [1].
Desarrollo de reservas del 2T26 con dos cifras	Baja	Nota de prensa: 860 M en el trimestre; cuadro de reservas del 10-Q: 1.250 M en el semestre frente a 1.050 M del 1T26 [5, 6, 8].
Investigaciones sobre Medicare Advantage	Alta	Demanda del DOJ por ajuste de riesgo (False Claims Act) pendiente desde 2017, sin estimación posible; las investigaciones abiertas en 2025 se tratan en riesgos [1].

10. Rentabilidad sobre el capital

Confianza: Media

Periodo	ROIC	ROE	ROA	Margen neto	Rotación del activo	Apalancamiento	Capital invertido
2016	13,0 %	18,3 %	5,7 %	3,8 %	1,51x	3,21x	59.884
2017	18,3 %	24,5 %	8,1 %	5,2 %	1,54x	3,04x	64.054
2018	18,4 %	24,1 %	8,2 %	5,3 %	1,55x	2,93x	73.341
2019	18,7 %	25,3 %	8,5 %	5,7 %	1,49x	2,98x	83.526
2020	18,6 %	25,0 %	8,3 %	6,0 %	1,39x	3,02x	91.410
2021	19,8 %	25,2 %	8,4 %	6,0 %	1,40x	2,98x	96.400
2022	20,8 %	26,9 %	8,8 %	6,2 %	1,42x	3,06x	107.317
2023	20,8 %	26,9 %	8,6 %	6,0 %	1,43x	3,12x	123.944
2024	17,4 %	15,9 %	5,0 %	3,6 %	1,40x	3,15x	141.105
2025	12,5 %	12,9 %	4,0 %	2,7 %	1,47x	3,25x	151.174

ROIC incremental (variación del NOPAT sobre variación del capital invertido en el periodo): 12,2 % · **WACC**: 8,9 %.

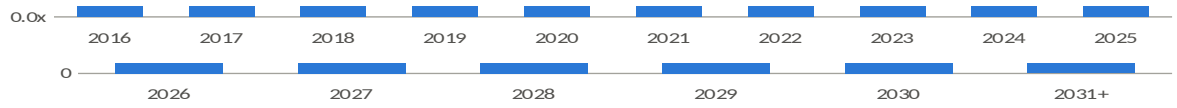
UnitedHealth creó valor con holgura hasta 2023: ROIC del 18-21 % entre 2017 y 2023, más del doble de su coste de capital (8,92 %). En 2025 bajó al 12,5 %, aún por encima del WACC, y la causa es el margen, no la rotación: el margen neto pasó del 6,0 % (2023) al 2,7 % (2025) mientras la rotación del capital se mantenía en 1,4-1,5 veces. El ROIC incremental de 2016-2025 es del 12,2 %, por debajo del ROIC medio del periodo: las compras de 2022-2024 (Change Healthcare, LHC, Amedisys, consultas de Optum Health) rinden menos que el negocio original, y el fondo de comercio e intangibles llegaron a 130.973 M en 2025 [1]. Dos matices: el NOPAT incluye el rendimiento de las inversiones

reguladas (3.920 M en 2025) y el capital invertido descuenta la caja a corto pero no las inversiones a largo; con toda la cartera regulada dentro, el ROIC sería unos dos puntos más bajo (estimación propia). Frente a los comparables (mediana 8,7 %), sigue siendo el mejor del grupo.

11. Deuda y solvencia

Confianza: Alta

Deuda neta a 30 jun 2026	**72.228 M**	Deuda neta / EBITDA últimos 12 m	**2,5x**
Pasivos asimilables a deuda (pensiones y otros)	**5.000 M**	Deuda neta ajustada	**77.228 M**
Deuda neta ajustada / EBITDA	**2,7x**	Liquidez disponible	**A 30-jun-2026: caja y equivalentes 28.585 M e inversiones a corto 2.883 M, de los que solo unos 1.100 M estaban disponibles para uso general de la matriz (el resto está en filiales reguladas); sin papel comercial en circulación; tres líneas de crédito bancarias de 7.000 M cada una (a cinco años, tres años y 364 días; vencen en nov-2030, nov-2028 y nov-2026), sin disponer, que respaldan el programa de papel comercial [1, 5].**
Rating	**Moody's A2 (perspectiva negativa); S&P A+ (negativa); Fitch A (negativa); A.M. Best A- (estable), a 31-dic-2025 [1].**	Coste medio de la deuda	**5,2 %**



Covenants, pasivos fuera de la deuda y contingencias

Pasivos que no son deuda financiera pero pesan: medical costs payable de 39.337 M a cierre de 2025 (38.930 M a 30-jun-2026), con 26.700 M de IBNR, casi todo del año corriente; unos 90 % de los siniestros se conocen y liquidan en 90 días [1, 5]. Otros pasivos corrientes de 28.046 M incluyen 13.900 M de depósitos HSA y 1.600 M de certificados de depósito de Optum Bank, reembolsos de primas y saldos de clientes [1]. Minoritarios: redimibles 1.608 M (fuera del patrimonio; bajaron desde 4.323 M por una desconsolidación) y no redimibles 5.980 M [1]. Opciones de compra y venta de transacciones de cartera valoradas en 630 M en otros pasivos (2024) [2]. Arrendamientos operativos 4.615 M, fuera de la deuda (US GAAP) [1, 12]. Compromisos de compra de 8.100 M (2.500 M en 12 meses) [1]. Pleitos: demanda del DOJ de 2017 por ajuste de riesgo de Medicare Advantage (False Claims Act), sin estimación posible [1]. Cumplimiento de covenants de las líneas bancarias a 31-dic-2025 [1].

12. Asignación de capital

Confianza: Media

Dividendo trimestral de 2,21 USD desde junio de 2025 (8,84 USD anuales) y de 2,32 USD desde junio de 2026 [1, 12]. Recompras: autorización del consejo para 21 millones de acciones a cierre de 2025; 5.545 M recomprados en 2025 y compromiso de al menos 5.000 M en 2026 (4.000 M hechos hasta mediados de julio) [1, 8]. Prioridad declarada: bajar la deuda/capital al ~40 % a finales de 2026 (41,2 % en junio) [8]. La caja de la matriz depende de los dividendos de las filiales reguladas (9.200 M en 2024; aportación neta de 535 M en 2025) y del flujo de los negocios no regulados [1].

Periodo	FCF	Adquisiciones	Dividendos	Recompras	Ampliaciones	Retorno / B. neto	Acciones (M)
2016	8.090	1.760	2.261	1.280	429	50 %	968,0
2017	11.573	2.131	2.773	1.500	688	40 %	985,0
2018	13.650	5.997	3.320	4.500	838	65 %	983,0
2019	16.392	8.343	3.932	5.500	1.037	68 %	966,0
2020	20.123	7.139	4.584	4.250	1.440	57 %	961,0
2021	19.889	4.821	5.280	5.000	1.355	59 %	956,0
2022	23.404	21.458	5.991	7.000	1.253	65 %	950,0
2023	25.682	10.136	6.761	8.000	1.353	66 %	938,0
2024	20.705	13.408	7.533	9.000	1.846	115 %	929,0
2025	16.075	4.509	7.916	5.545	827	112 %	911,0



Historial de adquisiciones

Año	Objetivo	Importe	Financiación	Resultado
2019	DaVita Medical Group (Optum Health)	4.300	Caja y deuda	Acuerdo de dic-2017 por unos 4.300 M; 8.343 M pagados en compras en 2019. Optum Health pasó de 2.963 M de resultado en 2019 a 7.770 M en 2024 y a −278 M en 2025 [3, 4, 12].
2022	Change Healthcare y otras (Optum Insight)	12.000	Caja y nueva deuda (la deuda a largo pasó de 42.383 M a 54.513 M)	Capital previsto de unos 12.000 M sin deuda asumida; 21.458 M pagados en compras en 2022. Ciberataque de feb-2024: 9.033 M de préstamos a proveedores y 799 M de provisión en 2025; el resultado de Optum Insight cayó de 4.268 M (2023) a 2.624 M (2025) [1, 2, 3, 12].
2023	Compras de 2023 (sobre todo Optum Health)	10.136	Caja y deuda	Importe en efectivo neto de caja adquirida; el fondo de comercio sube de 93.352 M a 103.732 M [12].
2024	Compras de 2024	13.408	Caja y deuda (la deuda sube 14.367 M)	Importe en efectivo neto de caja adquirida; en 2025 parte de Optum Health se vende o se cierra con pérdidas de 821 M [1, 12].
2025	Varias combinaciones de negocios	4.800	Caja	Contraprestación total de 4.800 M (4.509 M en efectivo neto) [1, 12].
2026	Alegeus Technologies (Optum Insight)	–	No publicada	Cerrada el 2-jul-2026; neutral para el beneficio de 2026 según la empresa [8, 9].

Entre 2016 y 2025 la empresa generó 201.259 M de flujo operativo, invirtió 25.676 M en capex y 79.702 M en compras, pagó 50.351 M en dividendos y 51.575 M en recompras, y recibió 11.066 M por emisión de acciones de empleados [12]. Las acciones diluidas bajaron de 968 a 911 millones [12]. Desinversiones con pérdidas: Brasil en 2024 (7.100 M, 4.100 M por conversión de divisas) y el resto de Sudamérica (1.200 M en 2024; venta prevista para el segundo semestre de 2026) [1, 2]. En 2026 vendió Optum UK y dedica sus 400 M netos a la United Health Foundation [9].

Parte III — Equipo y gobierno

13. Equipo directivo

Confianza: Alta

Nombre	Cargo	Desde	% capital	Trayectoria y resultados
Stephen J. Hemsley	Presidente del consejo y consejero delegado (Chair and CEO)	2025	0,15 %	En la empresa desde 1997 y consejero desde 2000; consejero delegado de 2006 a 2017, presidente ejecutivo de 2017 a 2019 y presidente no ejecutivo de 2019 a mayo de 2025, cuando vuelve como consejero delegado tras la salida de Andrew Witty, que dejó también el consejo el 20-may-2025 y renunció a sus acciones por resultados de 2025 [1, 31, 37, 40]. Bajo su segundo mandato la guía de 2025 se rehízo desde cero (al menos 16,00 USD de BPA ajustado, real 16,35) y la de 2026 se ha elevado dos veces, de más de 17,75 a 19,50-20,00 USD [8, 10, 57]. Posee 1.335.742 acciones (0,15 %), con 280.500 en fundaciones y 692.255 en fideicomisos; compró 86.700 acciones por 25,0 M USD el 16-may-2025 [32, 46].
Wayne S. DeVeydt	Director financiero (EVP and CFO)	2025	0,00 %	Fichado de fuera el 2-sep-2025: director gerente de Bain Capital (2022-2025), consejero delegado (2018-2020) y presidente ejecutivo (2020-2025) de Surgery Partners, y director financiero de Elevance Health (Anthem) de 2007 a 2016 [1, 38]. Sustituye a John Rex, director financiero desde 2016, que pasó a asesor estratégico del consejero delegado [38]. Remuneración 2025 de 14,58 M USD, con una prima de fichaje de 1,2 M sujeta a recuperación [32].
Patrick Conway, M.D.	Consejero delegado de Optum	2025	0,01 %	Consejero delegado de Optum desde el 6-may-2025, tras dirigir Optum Rx; en el grupo desde 2020. Antes, director médico y administrador en funciones de los CMS y director del CMS Innovation Center [1, 45]. Es el único alto directivo con ventas en mercado en los últimos 12 meses (2.469 acciones, 0,95 M USD en 2026) [46].
Timothy Noel	Consejero delegado de UnitedHealthcare	2025	0,01 %	Consejero delegado de UnitedHealthcare desde enero de 2025; antes dirigía Medicare & Retirement, negocio del que fue director financiero; en el grupo desde 2007 [1]. Le tocó gestionar el repunte del coste médico de Medicare Advantage de 2025 que obligó a retirar la guía [56].
Christopher Zaetta	Director jurídico y secretario del consejo (EVP, Chief Legal Officer)	2024	0,01 %	Director jurídico desde mayo de 2024; antes director jurídico de Optum (2020-2024) y responsable de litigios del grupo (2011-2019) [1]. Coordina la respuesta a las investigaciones penal y civil del DOJ sobre Medicare Advantage [30].

¿Cumple lo que promete?

Año	Lo que prometió	Lo que logró	Cumplió
2023	BPA ajustado 24,40-24,90 USD (nov-2022) [51]	BPA ajustado 25,12 USD [53]	Sí
2024	BPA ajustado 27,50-28,00 USD (nov-2023) [52]	BPA ajustado 27,66 USD, en la parte baja pese al ciberataque de Change Healthcare [54]	Sí
2025	BPA ajustado 29,50-30,00 USD (dic-2024, reafirmada en ene-2025) [54]; rebajada a 26,00-26,50 el 17-abr [55], retirada el 13-may [56], repuesta en al menos 16,00 el 29-jul [57] y elevada a al menos 16,25 el 28-oct [11]	BPA ajustado 16,35 USD (GAAP 13,23), un 45 % por debajo de la guía inicial [10]	No
2026	BPA ajustado de más de 17,75 USD (27-ene-2026) [10]; elevada a más de 18,25 el 21-abr [58] y a 19,50-20,00 el 16-jul [8]	En curso: BPA ajustado de 13,61 USD en el primer semestre (7,23 + 6,38) [8, 58]	Parcial

La cúpula se renovó casi entera en 2025: nuevo consejero delegado (Hemsley, mayo), nuevo jefe de Optum (Conway, mayo), de UnitedHealthcare (Noel, enero), nuevo director financiero externo (DeVeydt, septiembre) y nuevo responsable contable (Stankiewicz, marzo de 2026) [1, 37, 38, 44, 45]. El historial de guía era fiable hasta 2024 y se rompió en 2025: la guía inicial de 29,50-30,00 USD acabó en 16,35, con una retirada a mitad de año [10, 54, 56]. La de 2026 se ha elevado dos veces [8, 58]. La sucesión es la debilidad: Hemsley tiene 73 años, su opción de 60 M USD se consolida de golpe en mayo de 2028 y no hay sucesor designado públicamente [32, 37].

14. Gobierno corporativo

Confianza: Alta

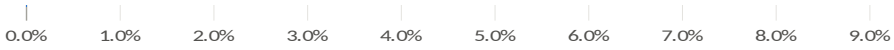
Consejeros	**9**	Independientes	**89 %**
Antigüedad media en el consejo	**8,0 años**	Criterios de buen gobierno cumplidos	**11 de 13**
Cambios de presidente o primer ejecutivo (24 meses)	**1**		

Consejero	Cargo	Tipo	Desde	Comisiones
Stephen J. Hemsley	Presidente y consejero delegado	Ejecutivo	2000	Ninguna
F. William McNabb III	Consejero independiente coordinador (Lead Independent Director desde ago-2025)	Independiente	2018	Remuneración y Recursos Humanos; Gobierno (desde jun-2026); miembro nato sin voto de todas
Timothy Flynn	Consejero	Independiente	2017	Auditoría y Finanzas (presidente); Gobierno; Responsabilidad Pública
Charles Baker	Consejero	Independiente	2023	Gobierno (presidente); Auditoría y Finanzas; Responsabilidad Pública
Paul Garcia	Consejero	Independiente	2021	Remuneración y Recursos Humanos (presidente); Responsabilidad Pública
Kristen Gil	Consejera	Independiente	2022	Auditoría y Finanzas
Scott Gottlieb, M.D.	Consejero	Independiente	2025	Responsabilidad Pública (presidente desde jun-2026); Políticas Sanitarias y Clínicas
Valerie Montgomery Rice, M.D.	Consejera	Independiente	2017	Políticas Sanitarias y Clínicas (presidenta); Remuneración y Recursos Humanos
John Noseworthy, M.D.	Consejero	Independiente	2019	Remuneración y Recursos Humanos; Políticas Sanitarias y Clínicas

Criterio	Dato	Resultado
Consejeros independientes ≥ 50 % (≥ 33 % si hay accionista de control)	89 %	Cumple
Presidencia sin vínculo familiar ni profesional con el accionista de control	Sin control	Cumple
Presidente no ejecutivo, o consejero coordinador independiente	Ejecutivo, con coordinador	Cumple
Comisión de auditoría con mayoría de independientes y presidida por uno	Sí	Cumple
Ningún consejero «otro externo» con más de 12 años	Ninguno	Cumple
Estabilidad de la cúpula: como mucho un cambio de presidente o primer ejecutivo en 24 meses	1 cambio	Cumple
Peor voto en contra sobre remuneración (3 juntas) ≤ 20 %	39,8 % en contra	No cumple
Variable a largo plazo ligado a rentabilidad (ROIC, TSR, FCF)	Sí	Cumple
Una acción, un voto, sin blindajes ni límites de voto estatutarios	Sí	Cumple
Sin operaciones vinculadas relevantes	No hay	Cumple
Auditor con 10 años o menos en el cargo	24 años	No cumple
Opinión de auditoría sin salvedades	Favorable	Cumple
Directivos compradores netos en 12 meses (o sin ventas relevantes)	Compras 31,60 / ventas 0,95 M	Cumple

Accionariado

Accionista	% capital	Tipo	Movimientos recientes
BlackRock, Inc.	7,99 %	Gestora (13G pasivo)	72,6 M de acciones según su 13G/A de febrero de 2024, el último que cita el proxy de 2026 [32]
Vanguard Capital Management	7,50 %	Gestora (13G pasivo)	Primer 13G el 30-abr-2026 (68,1 M de acciones) tras el realineamiento interno de Vanguard, que repartió la posición de The Vanguard Group (91,8 M, 10,08 % en mayo de 2025) entre sus filiales [47, 48, 49]
State Street Corporation	5,00 %	Gestora (13G pasivo)	Nuevo 13G de agosto de 2026 por 45,7 M de acciones [50]
Berkshire Hathaway	0,00 %	Inversor	Compró 5,04 M de acciones (cerca del 0,6 %) en el 2T25, las mantuvo a 31-dic-2025 y las vendió todas en el 1T26 [59, 60, 61]
Consejeros y directivos (16 personas)	0,19 %	Insiders	1,71 M de acciones a 2-abr-2026, de ellas 1,34 M de Hemsley [32]
Autocartera	0,00 %	Autocartera	Sin autocartera: las acciones emitidas y en circulación coinciden (897,6 M a 31-jul-2026); el primer semestre de 2026 recompró 10,5 M de acciones a 344,08 USD de media y quedan autorizadas 10,6 M [5]



Compras y ventas de consejeros y directivos (12 meses)

Fecha	Persona	Operación	Acciones	Importe (M)
21 ago 2026	Patrick Conway (CEO de Optum)	Venta	1.169	0,46
5 ago 2026	Patrick Conway (CEO de Optum)	Venta	500	0,21
23 abr 2026	Patrick Conway (CEO de Optum)	Venta	800	0,28
16 may 2025	Stephen Hemsley (CEO)	Compra	86.700	25,02
16 may 2025	John Rex (entonces presidente y CFO)	Compra	17.175	5,00
15 may 2025	Kristen Gil (consejera)	Compra	3.700	1,00
14 may 2025	Timothy Flynn (consejero)	Compra	1.533	0,49
14 may 2025	John Noseworthy (consejero)	Compra	300	0,09

Remuneración

Remuneración total del primer ejecutivo (2025)	**60,94 M**	Fijo	**0,60 M**
Variable anual	**0,00 M**	Variable a largo plazo	**60,00 M**
Peor voto a favor (3 juntas)	**60,0 %**	Peor voto en contra (3 juntas)	**39,8 %**
Ratio sobre salario medio	**748x**		

El consejero delegado cobra 1 M USD de fijo, sin bonus anual, y una única concesión de opciones de 60 M USD (mayo de 2025) que se consolida de golpe a los tres años, sin nuevas concesiones en ese plazo [37]. En febrero de 2026 se añadió la obligación de mantener las acciones netas hasta mayo de 2030 [42]. La remuneración total de 2025 fue de 60,94 M USD, 748 veces la del empleado mediano (81.474 USD) [32]. Para el resto de la cúpula, el bonus anual se mide por ingresos, resultado operativo, flujo de caja, NPS y clima laboral (tope de 2 veces el objetivo), y las acciones por resultados (50 % del incentivo a largo plazo) se reparten a partes iguales entre el BPA ajustado acumulado a tres años y el ROE medio [32]. Hay recuperación (clawback) por reformulación, fraude o conducta dañina [32]. Indemnización: dos años de salario más bonus [37, 38]. El voto consultivo cayó del 95,9 % a favor en 2024 [39] al 60,0 % en 2025 (39,8 % en contra) por la concesión de Hemsley [40]. La empresa respondió renunciando a concesiones anticipadas salvo casos extraordinarios y subiendo la exigencia de tenencia del CEO de 8 a 10 veces el salario; en 2026 obtuvo un 82,5 % (con las abstenciones como voto en contra) [32, 41].

Operaciones vinculadas, estructura de control y defensas

No hay accionista de control: los mayores son gestoras indexadas (BlackRock 7,99 %, Vanguard Capital Management 7,50 %, State Street 5,0 %) y el consejo y la dirección suman el 0,19 % [32, 49, 50]. Hay una sola clase de acciones, un voto por acción, elección anual de todos los consejeros por mayoría, y todas las comisiones son íntegramente independientes [32]. Desde mayo de 2025 se juntan los cargos de presidente y consejero delegado en Hemsley, tras casi 20 años separados; el contrapeso es un consejero coordinador con funciones reforzadas, McNabb, expresidente y exconsejero delegado de Vanguard, elegido en agosto de 2025 [32]. El consejo se ha renovado: cuatro independientes nuevos desde 2021 y una antigüedad media de 5,6 años; el último, el exdirector de la FDA Scott Gottlieb, en noviembre de 2025 [32, 43]. Las operaciones vinculadas son menores: familiares de Flynn, McSweeney y Zaetta empleados sin cargo directivo, y servicios cruzados con BlackRock (7,8 M USD de comisiones de gestión pagadas por UNH) [32].

Señales de alerta

- Investigaciones penal y civil del DOJ sobre las prácticas de Medicare Advantage, confirmadas por la empresa en julio de 2025; el 10-Q del 2T26 no da novedades ni las cuantifica [5, 30].
- Demanda por fraude bajo la False Claims Act sobre ajuste de riesgo en Medicare (denuncia de 2011, el DOJ se personó en 2017): el Special Master recomendó en marzo de 2025 fallar a favor de la empresa y el DOJ lo recurrió en abril; sin estimación de pérdidas [5].
- Demanda colectiva de accionistas encabezada por CalPERS: el 30-sep-2026 el juez desestimó 43 de las 48 declaraciones impugnadas y las acusaciones de uso de información privilegiada contra Witty y Hemsley, pero deja seguir la parte sobre las ventas de negocios que aportaron 3.300 M USD al beneficio de 2024 [63].
- Hacienda de EE. UU. (IRS) propuso en marzo de 2026 ajustes significativos por precios de transferencia con una filial extranjera en 2017-2020 y podría extenderlos a años posteriores; la empresa lo recurrirá [5].
- Compra de Amedisys (3.300 M USD) cerrada tras un acuerdo con el DOJ que obliga a vender al menos 164 centros de atención domiciliaria y paliativos (unos 528 M USD de ingresos) bajo un supervisor; sentencia firme en diciembre de 2025 [62].
- Ciberataque a Change Healthcare (feb-2024): unos 190 millones de afectados, 2.200 M USD de costes directos y 867 M de pérdida de negocio en 2024 [2]; en el 4T25 se provisionaron otros 799 M USD por préstamos a proveedores de difícil cobro [1].
- Rotación casi total de la cúpula en 2025-2026: nuevo CEO, nuevo CFO de fuera, nuevos jefes de Optum y UnitedHealthcare y nuevo responsable contable en marzo de 2026 [37, 38, 44, 45].
- Voto consultivo de remuneración de solo el 60,0 % a favor en 2025, y caída del apoyo a Timothy Flynn (presidente de Auditoría) al 86,8 % ese año [40].
- El 8-K de la junta de 2026 da un 82,74 % a favor del voto de remuneración, pero con sus propias cifras sale un 82,47 % [41].

Parte IV — Mercado y valoración

15. Previsiones de la compañía y consenso

Confianza: Media

El 16-jul-2026, con los resultados del 2T26, UnitedHealth elevó la guía de 2026: BPA GAAP de 18,45-18,95 USD (antes > 17,10) y BPA ajustado de 19,50-20,00 USD (antes > 17,75); resultado operativo > 25.450 M (antes > 24.000 M), con UnitedHealthcare > 12.000 M, Optum Health > 2.275 M, Optum Insight > 4.925 M y Optum Rx > 6.250 M; ratio de siniestralidad 88,1 % ± 25 pb (antes 88,8 % ± 50 pb); tipo impositivo ≈ 18,5 %; flujo operativo ≈ 24.000 M (antes > 18.000 M) y recompras de al menos 5.000 M (antes ≈ 2.500 M) [8]. El BPA ajustado excluye la amortización de intangibles (≈ 1,50 USD por acción en 2026, recurrente), las desinversiones y el impacto de Sudamérica y reestructuraciones [8]. Los resultados del 3T26 se publican el martes 13-oct-2026 antes de la apertura, con conferencia a las 8:00 (hora del Este) [68].

Periodo	Ingresos	EBITDA	EBIT	BPA	DPA	Fuente
2026e	446.947	29.540	25.696	18,44	9,19	MarketScreener, 26 analistas [65]; S&P Global vía StockAnalysis: ingresos 446.900 M y BPA ajustado 19,87 [67]
2027e	460.336	33.170	28.442	21,24	9,40	MarketScreener [65]; S&P Global vía StockAnalysis: ingresos 460.340 M y BPA ajustado 22,61 [67]
2028e	487.685	37.014	32.359	24,45	10,06	MarketScreener [65]

Nuestra proyección frente al consenso

Periodo	Ingresos propios	Ingresos consenso	Dif.	EBITDA propio	EBITDA consenso	Dif.
2026e	447.567	446.947	+0,1 %	29.539	29.540	0,0 %
2027e	460.994	460.336	+0,1 %	33.192	33.170	+0,1 %
2028e	486.349	487.685	-0,3 %	36.476	37.014	-1,5 %

Analistas	**26**	Comprar / mantener / vender	**22 / 4 / 0**
Precio objetivo medio	**480,60**	Rango de precios objetivo	**380,00 – 529,00**

Revisiones de estimaciones

No hay un histórico gratuito de revisiones del consenso, pero la guía marca su dirección: la empresa empezó 2026 con un BPA ajustado de «más de 17,75 USD» (27-ene), lo subió a más de 18,25 (21-abr) y a 19,50-20,00 (16-jul), con el ratio de siniestralidad bajado al 88,1 % ± 25 pb y el flujo operativo elevado a ≈ 24.000 M [8, 10, 58]. El BPA ajustado de consenso de 2026 (19,87 USD, S&P Global) ya está dentro de la guía, y el de 2027 (22,61) supone otro +14 % [67]. Los resultados del 1T26 superaron el consenso (7,23 frente a 6,58 USD) [14]. El riesgo de revisión a la baja se concentra en 2027: tarifas de Medicare Advantage del +2,48 % y salida de afiliados [25].

16. Comportamiento en bolsa

Confianza: Alta

Rentabilidad total (con dividendos).

Periodo	Acción	Índice	Sector
En el año	+17,2 %	+15,1 %	+11,7 %
1 año	+9,8 %	+20,5 %	+22,2 %
3 años (anual.)	-8,4 %	+23,0 %	+11,5 %
5 años (anual.)	+0,6 %	+13,9 %	+8,1 %
10 años (anual.)	+12,7 %	+15,6 %	+11,2 %



Beta (5 años, mensual)	**0,54**	Volatilidad anualizada (1 año)	**35,5 %**
Máxima caída (5 años)	**-61,4 %**		

UnitedHealth ha perdido un 8,4 % anual en tres años mientras el S&P 500 ganaba un 23,0 % anual: 2025 fue el peor año de su historia reciente (−33,1 %), con la retirada de la guía, la salida de Andrew Witty y las investigaciones del DOJ [30, 37, 56]. La caída máxima en cinco años es del −61,4 %. En 2026 la acción rebota un 17,2 % (frente al 15,1 % del índice), desde el mínimo de 255,97 USD del 27-mar hasta el máximo de 461,62 del 16-jul, día en que subió la guía [8, 64]. La mayor caída diaria del año, −19,6 % el 27-ene, coincidió con una guía 2026 por debajo de lo esperado y con el aviso de tarifas de Medicare Advantage para 2027 (+0,09 %) [26, 64]. La beta mensual de cinco años (0,54) infravalora el riesgo actual: la volatilidad de un año es del 35,5 %, propia de una acción en reestructuración y no de una defensiva.

17. Múltiplos frente a su historia

Confianza: Alta

Múltiplo	Actual	Mediana	Mínimo	Máximo	Percentil	Prima / descuento
EV/EBITDA últimos 12 meses (cierre de cada año)	14,7x	14,3x	11,8x	18,7x	70 %	+3 %
PER últimos 12 meses (cierre de cada año)	24,4x	22,1x	20,4x	32,6x	60 %	+10 %

A 379,30 USD, UnitedHealth cotiza a 14,7 veces el EBITDA de los últimos doce meses, en línea con su media de diez años (14,3x) y en el percentil 70, y a 24,4 veces el beneficio, un 10 % por encima de su media (22,1x). La aparente normalidad engaña: el EBITDA de los últimos doce meses (28.675 M, con los cargos de 2025 devueltos) aún está un 21 % por debajo del de 2023, de modo que el precio ya paga una parte de la recuperación. Medido sobre el beneficio de los próximos doce meses, el PER es de 18,4x, por debajo de los 20-25x a los que cotizó en 2019-2024, cuando el margen EBITDA rondaba el 9,5 %. Lo que ha cambiado es el perfil de riesgo: regulación de Medicare Advantage más dura, investigaciones federales y un ROIC que ha bajado del 20,8 % al 12,5 %.

18. Comparables cotizados

Confianza: Media

Las seis grandes aseguradoras de salud gestionada cotizadas en EE. UU. (Elevance, Cigna, CVS Health con Aetna, Humana, Centene y Molina), con la misma mezcla de primas de Medicare Advantage, Medicaid y planes de empresa, y dos aseguradoras pequeñas de crecimiento (Oscar, mercado individual del ACA; Alignment, Medicare Advantage).

Cigna y CVS añaden gestión de farmacia (PBM), como Optum Rx. No hay comparable directo de Optum Health ni de Optum Insight a escala.

Empresa	País	Capitaliz.	EV/Vtas	EV/ EBITDA LTM	EV/ EBITDA NTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC	DN/ EBITDA	FCF yield
UnitedHealth	US	341.977	0,9x	14,7x	13,1x	18,4x	+1,3 %	6,4 %	12,5 %	2,5x	6,9 %
Elevance Health	US	89.502	0,6x	13,3x	–	14,2x	-0,9 %	4,1 %	8,5 %	2,5x	7,0 %
The Cigna Group	US	74.629	0,3x	7,8x	–	8,6x	+5,0 %	4,5 %	13,4 %	1,9x	12,2 %
CVS Health	US	110.285	0,4x	10,3x	–	10,2x	+3,6 %	4,0 %	7,2 %	3,7x	10,7 %
Humana	US	51.859	0,4x	16,6x	–	28,0x	+14,8 %	2,5 %	8,1 %	2,2x	3,8 %
Centene	US	32.288	0,1x	5,3x	–	12,5x	+7,3 %	2,6 %	8,8 %	-2,4x	27,7 %
Molina Healthcare	US	10.258	0,2x	23,6x	–	22,5x	+11,2 %	0,9 %	3,7 %	-2,6x	2,6 %
Oscar Health	US	10.289	0,4x	10,2x	–	15,8x	+32,7 %	4,3 %	25,1 %	-5,5x	42,6 %
Alignment Healthcare	US	1.566	0,3x	13,8x	–	11,1x	+35,8 %	1,9 %	9,9 %	-4,2x	11,3 %

La primera fila es la empresa analizada (calculada con sus propios datos). Los estadísticos excluyen a la empresa.

Estadístico	EV/Vtas	EV/EBITDA LTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC
Mediana	0,4x	11,8x	13,4x	+9,3 %	3,3 %	8,7 %
Media	0,3x	12,6x	15,4x	+13,7 %	3,1 %	10,6 %
Percentil 25	0,3x	9,6x	10,9x	+4,7 %	2,4 %	7,9 %
Percentil 75	0,4x	14,5x	17,5x	+19,3 %	4,1 %	10,8 %

Valor implícito por acción

Múltiplo aplicado	Métrica de la empresa	Múltiplo p25 / mediana / p75	Valor p25	Valor mediana	Valor p75	Potencial
EV/EBITDA últimos 12 meses	28.675	9,6x / 11,8x / 14,5x	215,78	285,75	371,63	-24,7 %
PER próximos 12 meses	20,6	10,9x / 13,3x / 17,5x	224,32	275,37	360,45	-27,4 %
EV/Ventas últimos 12 meses	450.129	0,3x / 0,4x / 0,4x	35,27	100,18	122,64	-73,6 %



UnitedHealth cotiza con prima clara frente a sus comparables: 18,4 veces el beneficio de los próximos doce meses frente a una mediana de 13,4x (Elevance 14,2x, CVS 10,2x, Cigna 8,6x) [69, 70, 71]. Aplicado a su BPA, el PER mediano da 275,37 USD por acción, un 27 % por debajo del precio. La prima tiene fundamento parcial: Optum aporta más de la mitad del resultado operativo con negocios de servicios y tecnología sin equivalente cotizado, y el ROIC de UnitedHealth (12,5 %) supera la mediana del grupo (8,7 %). Pero ya no se sostiene por crecimiento: el consenso da a UnitedHealth un 1,6 % de crecimiento de ingresos a doce meses frente a una mediana del 9,3 %. Humana (28,0x) y Molina (22,5x) tienen el beneficio de 2026 hundido y empujan la media al alza; el EV/EBITDA de Centene, Molina, Oscar y Alignment no compara porque Stock Analysis resta su caja regulada [73, 74]. Usamos solo el PER y con un peso del 15 %.

19. Transacciones precedentes

Confianza: Media

Fecha	Objetivo	Comprador	EV (M)	EV/ Ventas	EV/ EBITDA	Prima	Comentario
2018-03	Express Scripts	Cigna	67.000	0,67x	9,2x	31 %	48,75 USD en efectivo + 0,2434 acciones por acción (54.000 M en total) y 15.000 M de deuda asumida; prima del 31 % sobre el cierre de 73,42 USD del 7-mar-2018 [88]. Múltiplos sobre 2017: ingresos 100.065 M y EBITDA 7.296 M (resultado operativo 5.494 + amortizaciones 1.802) [93] (cálculo propio).
2017-12	Aetna	CVS Health	77.000	1,27x	–	–	145 USD en efectivo + 0,8378 acciones de CVS por acción, ≈ 207 USD por acción y 69.000 M de capital; 77.000 M con la deuda asumida [89]. EV/ventas sobre los ingresos de 2017 de Aetna, 60.535 M [94] (cálculo propio).
2021-01	Change Healthcare	UnitedHealth Group (Optum)	12.521	4,05x	18,1x	–	25,75 USD por acción en efectivo [90]. Estimación propia del valor empresa: 304,45 M de acciones (27-oct-2020) × 25,75 = 7.840 M + deuda 4.818 M − caja 137 M (31-dic-2020) [95]. Múltiplos sobre el ejercicio cerrado en marzo de 2021: ingresos 3.090 M y EBITDA 691 M (resultado operativo 100 + amortizaciones 591) [95].
2023-06	Amedisys	UnitedHealth Group (Optum)	3.694	1,66x	17,9x	–	101 USD por acción en efectivo [91]. Estimación propia del valor empresa: 32,56 M de acciones × 101 = 3.289 M + deuda 400 M − caja 49 M + minoritarios 54 M (31-mar-2023) [96]. Múltiplos sobre 2022: ingresos 2.223 M y EBITDA 206 M (resultado operativo 181 + amortizaciones 25) [96].

Fecha	Objetivo	Comprador	EV (M)	EV/ Ventas	EV/ EBITDA	Prima	Comentario
2022-09	Signify Health	CVS Health	8.000	12,30x	67,8x	–	30,50 USD por acción en efectivo; valor total de la operación ≈ 8.000 M [92]. Sobre 2021: ingresos 653 M y EBITDA 118 M [97] (cálculo propio). Plataforma de evaluaciones domiciliarias en crecimiento: múltiplo no comparable con un asegurador.
2023-02	Oak Street Health	CVS Health	10.600	–	–	–	39 USD por acción en efectivo, valor empresa ≈ 10.600 M; red de atención primaria con EBITDA ajustado aún negativo, que CVS espera que aporte más de 2.000 M de EBITDA ajustado «embebido» en madurez [98].
2021-04	Kindred at Home (60 % restante)	Humana	8.100	–	–	–	Valor empresa de 8.100 M para el 100 %, incluidos 2.400 M del 40 % que Humana ya tenía; 43.000 cuidadores y más de 550.000 pacientes al año [99]. La nota no publica ingresos ni EBITDA.

EV/EBITDA mediano (p25 – p75)	**17,9x (13,6x – 18,0x)**	Prima de control mediana	**31 %**
Valor por acción implícito (mediana de EV/EBITDA)	**479,76**	Rango p25 – p75	**341,41 – 482,94**



Las operaciones del sector se han pagado a 9-18 veces el EBITDA: 9,2x por Express Scripts (Cigna, 2018), 18,1x por Change Healthcare y 17,9x por Amedisys (las dos de UnitedHealth, estimación del valor empresa a partir de sus cuentas) [88, 90, 91]. Son compras de negocios de servicios o de farmacia, no de aseguradoras enteras, y llevan prima de control (31 % en Express Scripts). Con un valor de mercado de 342.000 M USD, UnitedHealth no es objeto plausible de una compra, y la propia empresa está ahora vendiendo activos (Sudamérica, Optum UK) y obligada a desinvertir 164 centros de Amedisys [1, 62]. La mediana da 479,76 USD por acción, pero no la ponderamos: no hay comprador posible y los múltiplos son de piezas, no del conjunto.

20. Descuento de flujos de caja (DCF)

Confianza: Media

Supuestos y su justificación

Crecimiento de ingresos.

2026e se fija en el 0 % (ingresos de 447.567 M, igual que en 2025): el consenso da 446.947 M [65] y la empresa ha elegido margen frente a volumen, con 7,57 M de afiliados de Medicare Advantage a junio frente a 8,45 M a diciembre [5]. Para 2027e el 3,0 % coincide con el consenso (460.336 M) [65]: la tarifa de Medicare Advantage sube un 2,48 % [25] y sigue la salida de afiliados. Desde 2028e el crecimiento vuelve al 5,5 % y baja hasta el 4,0 % en 2032e, por debajo del gasto sanitario de EE. UU. (5,7 % anual previsto por CMS para 2024-2029) [17] y muy por debajo del 10,3 % anual de 2016-2025, que incluía compras por 79.702 M. El consenso de 2028e (487.685 M) queda un 0,3 % por encima de nuestra cifra.

Márgenes.

El margen EBITDA de 2026e (6,6 %) sale de la guía de resultado operativo de más de 25.450 M más ≈ 4.300 M de amortizaciones [8], y coincide con el consenso (29.540 M) [65]. Sube al 7,2 % en 2027e (consenso 7,2 %) y al 8,0 % en 2030e, por debajo del 9,1-9,8 % de 2019-2024. La palanca es el ratio de siniestralidad: pasó del 85,5 % (2024) al 89,1 % (2025) y la guía de 2026 es del 88,1 % ± 25 pb [1, 8]; volver al 86-87 % con las subidas de primas de 2026-2027 añade 1-1,5 puntos de margen. No suponemos la vuelta completa al 9,5 % porque el nuevo modelo de ajuste de riesgo (V28) y la reforma de los gestores de farmacia recortan ingresos por miembro [25, 34]. Cada punto de margen mueve el valor unos 73 USD por acción.

Inversión y circulante.

UnitedHealth apenas necesita capital: el capex fue del 0,8-0,9 % de las ventas en 2023-2025 y el circulante comercial es negativo (−2,6 % de las ventas en 2025), porque cobra primas antes de pagar a proveedores [1]. Proyectamos un capex del 1,1-1,2 %, por encima de su historia, para dejar sitio a compras pequeñas en Optum (la compra del 2-jul-2026, de 3.000 M, va en el puente) [5]; el último año supera a la amortización (1,0 %). El circulante se mantiene en el −2,6 %. Las reservas médicas (38.930 M) y los cobros anticipados quedan fuera: respaldan la caja regulada que también excluimos del puente. El tipo impositivo es el 18,5 % de la guía en 2026 y el 21 % después, en línea con 2019-2023.

Coste del capital.

Tasa libre: bono de EE. UU. a 10 años al 5,22 % (8-oct-2026) [85]. Beta de 0,85: la desapalancada de Damodaran para servicios sanitarios (0,74, corregida por caja) reapalancada con la deuda a mercado de UnitedHealth (20 % sobre el capital) [87]. No usamos la beta de la acción (0,54 mensual a cinco años; 0,43 semanal a dos años) porque refleja una caída idiosincrásica y no el riesgo sistemático [64]. Prima de mercado del 5,5 %; la implícita de Damodaran es del 4,20 % y el motor la usa en la regla relativa [86]. Coste de la deuda del 5,2 % antes de impuestos (intereses de 2025 sobre la deuda media), coherente con sus emisiones recientes al 5,3-5,95 % y su rating A2/A+/A [1]. Peso de la deuda del 16,8 % a valor razonable. Resultado: WACC del 8,92 %.

Valor terminal.

Crecimiento a perpetuidad del 3,0 %: inflación de largo plazo en dólares en torno al 2,5 % y algo de crecimiento real del gasto sanitario, que crece por encima del PIB (del 18,0 % del PIB en 2024 a 9,0 billones de USD en 2034, según CMS) [15, 16]. Está por debajo de la tasa libre menos medio punto (4,7 %). Gordon implica 11,8 veces el EBITDA de salida, por debajo de la media histórica de 14,3x y de la mediana de comparables (11,8x en EV/EBITDA de los últimos doce meses), lo que lo hace prudente. El valor terminal pesa el 71 % del valor empresa.

Coste medio ponderado del capital

Componente	Valor
Tasa libre de riesgo	5,22 %
Beta	0,85
Prima de riesgo de mercado	5,50 %
Prima adicional (país, tamaño, específica)	0,00 %
Coste de los fondos propios	9,89 %
Coste de la deuda antes de impuestos	5,20 %
Tipo impositivo	21,00 %
Coste de la deuda después de impuestos	4,11 %
Peso de la deuda (D / (D + E))	16,80 %
WACC	8,92 %
Prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa)	4,20 %
WACC con la prima implícita del mercado	8,00 %

Proyección

Año	Ingresos	Crec.	EBITDA	M. EBITDA	Amort.	Impuestos	Capex	Δ Circ.	FCFF	Fracción	VA
2026e	447.567	0,0 %	29.539	6,6 %	4.476	4.637	3.804	77	21.021	0,22	4.561
2027e	460.994	3,0 %	33.192	7,2 %	4.610	6.002	5.071	-349	22.468	1,00	21.115
2028e	486.349	5,5 %	36.476	7,5 %	4.863	6.639	5.593	-659	24.904	1,00	21.498
2029e	513.098	5,5 %	40.022	7,8 %	5.131	7.327	6.157	-695	27.233	1,00	21.569
2030e	538.753	5,0 %	43.100	8,0 %	5.388	7.920	6.465	-667	29.383	1,00	21.367
2031e	562.997	4,5 %	45.040	8,0 %	5.630	8.276	6.756	-630	30.638	1,00	20.456
2032e	585.516	4,0 %	46.841	8,0 %	5.855	8.607	7.026	-586	31.794	1,00	19.499

FCFF = EBIT × (1 − t) + amortizaciones − capex − variación del circulante. «Fracción» es la parte del ejercicio que queda por delante desde la fecha de valoración; VA, el valor actual.



Valor terminal

Concepto	Valor
Método principal	Crecimiento a perpetuidad
Crecimiento a perpetuidad	3,0 %
Múltiplo EV/EBITDA de salida	12,0x
Valor terminal (Gordon)	552.905
Valor terminal (múltiplo)	562.096
Múltiplo de salida implícito en Gordon	11,8x
Crecimiento implícito en el múltiplo	3,09 %
Peso del valor terminal en el valor empresa	71 %

Del valor empresa al valor por acción

Concepto	Importe
Valor actual de los flujos proyectados	130.064
Valor actual del valor terminal	324.905
Valor empresa	454.970
− Deuda financiera neta (con arrendamientos)	-72.228
− Minoritarios, pensiones y otros; + asociadas	-8.502
Valor de los fondos propios	374.240
Acciones diluidas (millones)	901,6
Valor por acción	415,08

Sensibilidad: WACC × Crecimiento a perpetuidad

WACC	2,0 %	2,5 %	3,0 %	3,5 %	4,0 %
7,9 %	436,82	473,69	518,05	572,44	640,69
8,4 %	395,41	425,80	461,79	505,10	558,19
8,9 %	360,04	385,42	415,08	450,22	492,50
9,4 %	329,46	350,91	375,69	404,66	438,96
9,9 %	302,79	321,08	342,02	366,22	394,51

Sensibilidad: margen EBITDA × crecimiento de ingresos (desplazamiento de toda la proyección)

Margen \ crec.	-2 pp	-1 pp	0 pp	+1 pp	+2 pp
-2 pp	230,07	248,77	268,41	289,04	310,69
-1 pp	296,36	318,50	341,75	366,14	391,73
0 pp	362,64	388,23	415,08	443,25	472,78
+1 pp	428,93	457,96	488,42	520,36	553,83
+2 pp	495,21	527,70	561,76	597,46	634,88

¿Puede la empresa sostener el crecimiento previsto?

Veredicto: En parte.

Prueba	Valor
Crecimiento medio de ingresos proyectado	3,9 %
Capex bruto medio (incluidas compras si van como inversión)	1,1 % de las ventas
Reinversión neta acumulada (capex − amortización + circulante)	1.410 M (1 % del NOPAT)

La proyección apenas necesita inversión neta de la amortización (reinversión acumulada de 1.410 M, el 1 % del NOPAT, con un capex bruto medio del 1,1 % de las ventas). En un negocio de activos ligeros, el crecimiento medio del

3,9 % tiene que salir de subir precios y de ganar volumen sin capital nuevo, y la prueba es el poder de precios y la cuota; en un comprador en serie, la amortización es de intangibles comprados y la prueba es el capex bruto (las compras) frente al crecimiento comprado.

Año	Volumen	Precio	Otros (mezcla, compras)	Crecimiento	De dónde sale
2026e	-3,5 %	+3,5 %	0,0 %	0,0 %	Volumen: los afiliados médicos de UnitedHealthcare bajan de 49,76 M a 48,53 M en el 1S26 y los de Medicare Advantage un 10 % [5]; las salidas son de alto ingreso por afiliado (estimación propia). Precio: tarifa de Medicare Advantage de 2026 del +5,06 % [27] y subidas de primas comerciales; Optum Rx crece con la inflación de los fármacos.
2027e	-1,0 %	+4,0 %	0,0 %	+3,0 %	Precio: tarifa de Medicare Advantage de 2027 del +2,48 % (4,98 % con la tendencia de riesgo) [25] y primas comerciales al ritmo del coste médico. Volumen: sigue la poda de planes de Medicare Advantage y de Medicaid (la ley OBBBA quita 2,6 M de inscritos al sector en 2027-2028) [29].
2028e	+1,5 %	+4,0 %	0,0 %	+5,5 %	Volumen: vuelta al crecimiento de afiliados con el envejecimiento de la población y Optum Rx ganando recetas (1.659 M en 2025) [1]. Precio: en línea con el gasto sanitario por persona.
2029e	+1,5 %	+4,0 %	0,0 %	+5,5 %	Mismo patrón que 2028e; por debajo del crecimiento del gasto sanitario nacional (5,7 %) [17].
2030e	+1,0 %	+4,0 %	0,0 %	+5,0 %	El volumen se modera: UnitedHealth ya tiene el 26 % de Medicare Advantage y el 16 % del seguro comercial [18, 29].

En parte. La proyección no pide capital (reinversión neta del 1 % del NOPAT): la prueba es el poder de precios y la cuota. El precio sí lo tiene: las primas siguen al coste médico con un año de retraso y la tarifa pública de Medicare Advantage sube un 2,48 % en 2027 [25]. La cuota no: UnitedHealth bajó del 29 % al 26 % de Medicare Advantage en un año [18] y pierde afiliados por decisión propia. Prueba de cuota a mano (el motor no puede hacerla porque la cuota publicada es de Medicare Advantage): los ingresos de 2025 equivalen al 7,9 % del gasto sanitario de EE. UU. (5,66 billones) [17]; nuestros 486.349 M de 2028e serían el 7,3 % de los 6,63 billones previstos, una cuota menor (estimación propia). El caso base crece menos que el mercado; lo exigente es el margen, no el crecimiento.

DCF inverso: qué descuenta el precio actual

Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2032e)	**3,2 % (base: 4,6 %)**
Margen EBITDA final implícito	**7,5 % (base: 8,0 %)**
Rentabilidad anual implícita (TIR al precio actual)	**9,4 % (WACC: 8,9 %)**

El DCF da 415,08 USD por acción, un 9,4 % por encima del precio, con un WACC del 8,92 % y un valor terminal que pesa el 71 %. El DCF inverso dice que el precio de 379,30 USD descuenta un crecimiento anual del 3,2 % en 2027e-2032e (frente a nuestro 4,6 %) o, con nuestro crecimiento, un margen EBITDA final del 7,5 % (frente a nuestro 8,0 % y al 9,1-9,8 % de 2019-2024); dicho de otro modo, el precio rinde un 9,4 % anual, medio punto más que nuestro coste de capital. No es una exigencia alta: el mercado ya paga una recuperación parcial del margen (del 6,6 % de 2026e a algo más del 7 %), pero no la vuelta a los niveles previos a 2025. Nuestras cifras de 2026-2028 coinciden con el consenso (EBITDA de 33.192 M en 2027e frente a 33.170 M), así que la diferencia entre valor y precio sale casi entera de la tasa de descuento: con la prima implícita del mercado (4,20 %), el DCF sube a 508,21 USD. La variable que decide es el ratio de siniestralidad: cada punto de margen EBITDA vale unos 73 USD por acción.

21. Escenarios

Confianza: Media

Escenario	Prob.	Crec. medio	Margen final	WACC	Valor	Potencial	Qué tiene que ocurrir
Bajista	25 %	3,1 %	6,5 %	9,4 %	245,27	-35,3 %	El coste médico no cede: el ratio de siniestralidad se queda en el 88-89 % de 2025-2026, las tarifas de Medicare Advantage de 2028 vuelven a subir poco y el DOJ cierra sus investigaciones con una multa y cambios en la codificación de riesgo. El margen EBITDA se queda en el 6,5 %, el nivel de 2025-2026, y el mercado exige más prima por el riesgo regulatorio. Es lo que ya le pasó a la empresa en 2025.
Base	50 %	4,6 %	8,0 %	8,9 %	415,08	+9,4 %	Se cumple la guía de 2026 y el consenso de 2027-2028: las subidas de primas recuperan el ratio de siniestralidad hacia el 87 %, Optum Health vuelve a márgenes positivos y el margen EBITDA llega al 8,0 % en 2030, todavía por debajo del de 2019-2024. Los ingresos crecen un 4,6 % anual desde 2027, menos que el gasto sanitario.
Alcista	25 %	5,6 %	9,0 %	8,9 %	520,36	+37,2 %	La disciplina de precios de Hemsley devuelve el margen EBITDA al 9 %, cerca del 9,1-9,8 % de 2019-2024, las investigaciones se cierran sin cargos materiales y la empresa vuelve a ganar afiliados en Medicare Advantage desde 2028.



Valor ponderado por probabilidad: 398,95 USD (+5,2 %).

La asimetría con nuestro coste de capital es de 1,05 veces: el alcista gana un 37,2 % (520,36 USD) y el bajista pierde un 35,3 % (245,27 USD), y el valor ponderado (398,95 USD) apenas supera el precio. El bajista no es cosmético: es el margen de 2025-2026 mantenido en el tiempo, algo que la empresa ya ha vivido. Con la prima implícita del mercado, la asimetría sube a 3,24 veces porque el alcista gana más con un WACC menor. Para un inversor que exija el 8,9 % de nuestro WACC, el perfil no compensa; para uno que se conforme con lo que hoy pide el mercado (8,0 %), sí.

22. Suma de partes

Confianza: Media

Con la guía de resultado operativo de 2026 por segmento y múltiplos de cada negocio, la suma de partes da 291,92 USD por acción (234,70-349,14 con ± 2 veces), un 23 % por debajo del precio. Optum vale el 55 % del valor empresa de la suma (187.925 de 343.925 M) y UnitedHealthcare el 45 %. La lectura es que el precio no se explica con los resultados de 2026: el mercado paga ya la recuperación de los márgenes de UnitedHealthcare y Optum Health. No aplicamos descuento de conglomerado: los negocios comparten clientes y datos (Optum Rx y Optum Health dan servicio a los afiliados de UnitedHealthcare) y las eliminaciones entre segmentos (173.436 M de ingresos en 2025) muestran esa integración [1]. Pesa un 15 % en la síntesis.

Negocio	Métrica	Valor de la métrica	Múltiplo	Valor empresa	Justificación del múltiplo
UnitedHealthcare	EBIT 2026e (guía)	12.000	13,0x	156.000	Aseguradora con margen deprimido (3,5 % en 2026e frente al 5-6 % de 2016-2024) [1, 8]: 13 veces el resultado operativo, cerca del EV/EBITDA de Elevance (13,3x) y por encima de CVS (10,3x), porque el resultado está en mínimos del ciclo [69, 71].
Optum Health	EBIT 2026e (guía)	2.275	15,0x	34.125	Atención sanitaria con riesgo (consultas y atención domiciliaria) con el margen hundido (≈ 2,4 % en 2026e, estimación propia frente al 7,4 % de 2024) [1, 8]: 15 veces un resultado que está en mínimos; las compras del área se pagaron a 17,9-18,1 veces el EBITDA [90, 91].
Optum Insight	EBIT 2026e (guía)	4.925	16,0x	78.800	Tecnología y servicios para hospitales y aseguradoras, con cartera de pedidos de 31.100 M [1]: 16 veces el resultado operativo, por debajo de los 18,1 veces el EBITDA pagados por Change Healthcare [90], por el riesgo del ciberataque y la pérdida de clientes.
Optum Rx	EBIT 2026e (guía)	6.250	12,0x	75.000	Gestor de farmacia: Cigna, cuyo resultado es mayoritariamente de Express Scripts, cotiza a 7,8 veces el EBITDA y se compró a 9,2 veces [70, 88]; aplicamos 12 veces el resultado operativo por el crecimiento (154.726 M de ingresos en 2025, +16 %) y a pesar de la reforma de los gestores de farmacia [1, 34].

Valor por acción por suma de partes: 291,92 (-23,0 %); con ±1x en los múltiplos, 234,70 – 349,14.

23. Síntesis de valoración

Confianza: Alta



Método	Mínimo	Central	Máximo
Cotización 52 semanas	255,97	379,30	461,62
Precio objetivo de los analistas	380,00	480,60	529,00
Comparables: PER NTM	224,32	275,37	360,45
Transacciones precedentes (EV/EBITDA)	341,41	479,76	482,94
DCF (WACC y g ± 0,5)	350,91	415,08	505,10
Escenarios (bajista – alcista)	245,27	398,95	520,36
Suma de partes	234,70	291,92	349,14
DCF con la prima del mercado	453,68	508,21	574,91
Precio actual	377,40	379,30	381,20

Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	415,08	+9,4 %	45 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	275,37	-27,4 %	15 %
Transacciones precedentes (no se usa)	479,76	+26,5 %	0 %
Suma de partes	291,92	-23,0 %	15 %
Escenarios ponderados	398,95	+5,2 %	25 %

Valor intrínseco ponderado (largo plazo): 371,62 USD (-2,0 % sobre 379,30).

El puente es del 10-Q del 2T26 (30-jun-2026): deuda de 73.328 M, minoritarios contables de 7.502 M (1.436 M rescatables y 6.066 M no rescatables), participadas de 4.000 M a valor contable y 5.000 M de otros ajustes (2.000 M de la recompra a plazo pagada el 1-jul, porque las acciones son las de la portada del 31-jul, y 3.000 M de la compra cerrada el 2-jul) [5]. La decisión clave es la caja: de los 28.585 M de caja y equivalentes, solo 1.100 M son de libre uso; el resto, con las inversiones a corto y largo (60.599 M más), respalda reservas médicas (38.930 M) y el capital estatutario (mínimo de 23.200 M) [1, 5]. Como su rendimiento ya está en el EBITDA, solo cuenta la caja no regulada; contar la caja y las inversiones a corto (31.468 M) añadiría unos 34 USD por acción. Pesos: el DCF y los escenarios (70 %) porque el valor depende de la recuperación del margen; comparables (PER) y suma de partes, un 15 % cada uno, porque reflejan el resultado deprimido de 2026; transacciones, nada, porque no hay operación posible.

Objetivo a 12 meses: nuestro PER × nuestro BPA

Escenario	BPA	PER	De dónde sale el PER	Precio	Rentabilidad
Bajista	16,33	16,0x	base × 0.8	261,28	-28,8 %
Base	23,45	20,0x	PER actual (18.2x) × 1.1 (tope: la mediana de 5 años, 23.7x, queda más lejos)	469,00	+26,0 %
Alcista	28,33	23,9x	media histórica larga	677,09	+80,9 %

Objetivo a 12 meses (ponderado): 469,09 USD · rentabilidad +26,0 % (base +26,0 %) · señal Mantener.

Para comparar, con la regla v2 (historia al cierre, mismo precio): 15,5x / 18,2x / 23,0x, 18,2 % Mantener; con el tope anterior del base (×1,3, 14-oct mediodía): 29,2 % Mantener. Decide la regla vigente (v3 con tope ×1,1; METODO-VIGENTE.md).

Frente al consenso (solo contraste).

Nuestro BPA base de 2028e (23,45) se separa un -4,1 % del consenso (24,45) y nuestro precio base (426,79) un -11,2 % del objetivo medio de los analistas (480,60). No se acerca la cifra: el porqué (ventas, margen, base de BPA o múltiplo) está en el contraste con el consenso de revision-12m-2026-10-13.md.

Del valor intrínseco al objetivo a 12 meses.

Valor intrínseco 371,62 (-2,0 %) frente al objetivo a 12 meses ponderado 439,57 (+18,3 % con dividendo; base +14,9 %). La distancia es menor del 25 %.

Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento

24. Catalizadores

Confianza: Media

Fecha	Evento	Qué se sabrá	Prob.	Sentido
13-oct-2026	Resultados del 3T26 y posible revisión de la guía de 2026 [68]	El ratio de siniestralidad del trimestre frente a la guía anual del 88,1 % y el desarrollo de reservas; las opciones descuentan un movimiento de ≈ 7 % [107]	Alta	+/−
15-oct a 7-dic-2026	Inscripción abierta de Medicare para 2027	Primera lectura de cuántos afiliados de Medicare Advantage pierde tras cerrar planes; Humana mejoró sus estrellas y UnitedHealth no [108]	Alta	+/−
Enero de 2027	Resultados de 2026 y guía de 2027	Primera guía con tarifas de Medicare Advantage del +2,48 %; el consenso espera un BPA ajustado de 22,61 USD [25, 67]	Alta	+/−
Finales de enero de 2027	Aviso de tarifas de Medicare Advantage para 2028 (CMS)	El aviso de 2027 (+0,09 %) costó un −19,6 % en un día; el comunicado final llega en abril [26, 64]	Alta	+/−
Sin fecha	Cierre de las investigaciones penal y civil del DOJ sobre Medicare Advantage	Multa o acuerdo y posibles cambios en la codificación de riesgo; la empresa no las cuantifica [5, 30]	Media	–
2S26-2027	Venta del resto de Sudamérica y desinversión de 164 centros de Amedisys	Simplifica la cartera; efecto pequeño en el valor [1, 62]	Media	+

25. Riesgos y pre-mortem

Confianza: Media

#	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Efecto en valor	Mitigante	Señal de alerta
1	**Coste médico por encima de las primas: el ratio de siniestralidad no vuelve al 86-87 %**	Operativo	Media	Alto	−35 % en el escenario bajista; ≈ −13 % por cada punto de ratio (estimación propia)	Repricing anual de las primas comerciales y salida de planes de Medicare Advantage poco rentables	Ratio de siniestralidad trimestral por encima del 88,5 % sin desarrollo favorable de reservas
2	**Investigaciones penal y civil del DOJ sobre la codificación de riesgo en Medicare Advantage y demanda bajo la False Claims Act**	Legal y regulatorio	Media	Alto	Multa no cuantificable; si cambia la codificación, −1 punto de margen ≈ −18 %	El Special Master recomendó fallar a favor de la empresa en la demanda de 2017 [5]	Acuerdo o acusación del DOJ; nuevas citaciones en el 10-Q
3	**Tarifas de Medicare Advantage y ajuste de riesgo (V28) más duros en 2028**	Regulatorio	Media	Alto	−10 a −15 % (estimación propia: 0,5-1 punto de margen)	CMS mantuvo el modelo de 2024 para 2027 y subió la tarifa al 2,48 % en el comunicado final [25]	Aviso de tarifas de 2028 por debajo del +2 %
4	**Reservas: los resultados de 2026 se apoyan en desarrollo favorable de ejercicios anteriores (1.250 M en el 1S26)**	Contable	Media	Medio	−5 % si no se repite (≈ 0,3 puntos de margen)	Días de siniestros pendientes estables (47,0 en el 2T26) [8]	Desarrollo desfavorable de reservas o caída de los días de siniestros pendientes
5	**Reforma de los gestores de farmacia y presión sobre Optum Rx**	Regulatorio	Alta	Medio	−5 a −8 % (estimación propia)	La ley de febrero de 2026 desvincula la remuneración del precio en Part D, no la elimina [34]	Margen de Optum Rx por debajo del 3,5 %
6	**Sucesión: Hemsley tiene 73 años y su opción de 60 M USD se consolida en 2028**	Gobierno	Media	Medio	Prima de riesgo +0,5 puntos ≈ −10 %	Nuevo CFO externo y nuevos jefes de Optum y UnitedHealthcare [38, 45]	Salidas en la cúpula o ausencia de sucesor designado en 2027
7	**Litigios: demanda colectiva de CalPERS, ajustes del IRS por precios de transferencia y reclamaciones del ciberataque de Change Healthcare**	Legal	Media	Bajo	−2 a −4 %	El juez desestimó 43 de 48 declaraciones de la demanda de CalPERS [63]	Provisiones nuevas en el 10-Q
8	**Recortes de Medicaid y fin de los subsidios reforzados del ACA**	Regulatorio	Alta	Bajo	−2 a −3 %	La empresa ya redujo Medicaid (6,78 M de afiliados a junio frente a 7,38 M en diciembre) [5]	Ratio de siniestralidad de Medicaid por encima del 92 %

Pre-mortem

Octubre de 2029: la acción vale 230 USD y ha perdido un 40 %. La recuperación de 2026 fue en parte contable: el desarrollo favorable de reservas (1.250 M en el primer semestre) se agotó en 2027 y el ratio de siniestralidad volvió al 89 %, porque la utilización de servicios en mayores y los fármacos GLP-1 siguieron subiendo más deprisa que las primas. CMS, con el foco político en los «sobrepagos» a Medicare Advantage, publicó tarifas planas para 2028 y 2029 y endureció la revisión de diagnósticos. En 2028 el DOJ cerró sus investigaciones con un acuerdo multimillonario y la obligación de cambiar la codificación de riesgo, lo que restó ingresos por afiliado de forma permanente. Hemsley cumplió los 76, cobró su opción y dejó la empresa sin un sucesor claro. El margen EBITDA se quedó en el 6,5 % y el mercado dejó de pagar la prima frente a Elevance y Cigna: con 13 veces el beneficio, el precio cayó por debajo de 250 USD. Los indicadores que lo habrían anticipado: el ratio de siniestralidad trimestral sin el desarrollo de reservas, el aviso de tarifas de enero de 2027 y los días de siniestros pendientes.

26. ESG y controversias

Confianza: Media

Proveedor	Calificación	Fecha
Morningstar Sustainalytics (riesgo ESG)	14,5, riesgo bajo (ambiental 0,1; social 10,7; gobierno 3,7) [35]	2026-10

Asuntos materiales

El primer asunto material es la ciberseguridad y la privacidad de datos de salud: el ataque a Change Healthcare de febrero de 2024 afectó a unos 190 M de personas, costó 2.200 M USD de respuesta directa en 2024 y 867 M de negocio perdido en Optum Insight, obligó a prestar más de 9.000 M sin intereses a proveedores y aún en el 4T25 exigió 799 M de provisiones por esos préstamos [1, 2]. El segundo es el acceso a la atención y la integridad de la facturación a Medicare: el ajuste por riesgo y la codificación de diagnósticos están bajo auditoría de CMS (RADV) y del DOJ [1, 30]. El tercero, la asequibilidad: el compromiso de devolver el beneficio de 2026 del seguro individual del ACA [5].

Controversias

Ciberataque a Change Healthcare (21-feb-2024) [2]. Asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Nueva York el 4-dic-2024, que abrió un debate público sobre la denegación de coberturas [33]. Investigaciones penal y civil del DOJ sobre Medicare Advantage, comunicadas el 24-jul-2025 [30]. Demanda por la ley de reclamaciones falsas (False Claims Act) sobre el ajuste por riesgo, asumida por el DOJ en 2017: en marzo de 2025 un perito judicial recomendó fallar a favor de la empresa y el DOJ lo recurrió en abril de 2025 [1, 5].

27. Preguntas abiertas para la dirección y la due diligence

Confianza: Media

#	Tema	Pregunta	Por qué importa
1	**Reservas**	¿Qué parte de la mejora del ratio de siniestralidad de 2026 viene del desarrollo favorable de reservas (860 M en el 2T26 según la nota de prensa, 200 M según el 10-Q) y qué ratio subyacente esperan para 2027?	Sin las reservas, el ratio del 2T26 (86,7 %) sería más alto; cada punto vale ≈ 13 % del valor.
2	**DOJ**	¿En qué fase están las investigaciones penal y civil sobre Medicare Advantage y qué prácticas de codificación se han cambiado ya?	El 10-Q del 2T26 no las cuantifica ni da novedades; es el mayor riesgo binario.
3	**Medicare Advantage**	¿Cuántos afiliados esperan perder en 2027 y con qué margen objetivo por afiliado?	La cuota cayó del 29 % al 26 % en un año; la estrategia de margen frente a volumen decide el crecimiento del DCF.
4	**Optum Health**	¿Qué margen operativo es alcanzable en Optum Health en 2028 tras la poda de contratos de riesgo y la venta de centros?	Pasó de 7.770 M de resultado en 2024 a −278 M en 2025; es la parte de la suma de partes con más recorrido.
5	**Caja**	¿Cuándo volverán las filiales reguladas a pagar dividendos a la matriz (9.200 M en 2024; aportación neta de 535 M en 2025)?	Solo 1.100 M de la caja son libres; la recompra de 5.000 M de 2026 depende de esos dividendos.
6	**Sucesión**	¿Hay un plan de sucesión de Hemsley antes de que se consolide su opción en 2028?	Rotación casi total de la cúpula en 2025-2026 y presidente y CEO en la misma persona.
7	**Optum Rx**	¿Cuánto resultado de Optum Rx depende de remuneraciones ligadas al precio de los fármacos que la reforma de 2026 desvincula?	Optum Rx aporta ≈ 25 % del resultado operativo del grupo en 2026e.

28. Sentimiento en foros y comentarios

Confianza: Baja

Tono: Dividido · **Tendencia:** Empeora

Dónde	Fecha	Comentarios	Tono	Qué se dice
Seeking Alpha (artículos de colaboradores y noticias sobre UNH, canal RSS del valor)	2026-10	14	Dividido	Entre mediados de agosto y el 12 de octubre los colaboradores pasan de «es hora de comprar la recuperación» y «la recuperación de márgenes da más recorrido» (septiembre) a «el potencial se ha agotado», «la recuperación funciona, la acción no» y una rebaja de recomendación (finales de septiembre y octubre); solo se leyeron titulares y fechas, porque las páginas devuelven 403 [100].
The Motley Fool (artículos de opinión para particulares)	2026-10	6	Positivo	Tono comprador: presentan a UNH como una historia de recuperación con valoración razonable y dividendo más alto de lo habitual, aunque admiten que el entusiasmo se ha enfriado desde el máximo de julio y que el margen comercial tardará más en recuperarse [101, 102, 103, 104, 105].
TipRanks (indicador de carteras de particulares y de blogueros)	2026-10	2	Dividido	El indicador de carteras de particulares marca «muy negativo» (reducen posiciones en los últimos 7 y 30 días) mientras el de blogueros sale alcista y por encima de la media del sector; el avance de resultados subraya que la acción cayó con fuerza tras batir previsiones en enero [106, 107].
Insider Monkey y Yahoo Finance (artículos de opinión)	2026-10	2	Neutro	Prudentemente positivos: el múltiplo «se ha reajustado» y puede descontar ya buena parte de lo malo, pero ingresos casi planos y márgenes estrechos dejan poco margen para decepcionar; destacan la venta de clínicas de Florida a TPG y la simplificación de Optum Health [110, 111].
24/7 Wall St. (artículos de mercado y de finanzas personales)	2026-10	2	Neutro	UNH «se mantiene» mientras Humana sube con fuerza por sus estrellas de Medicare y CVS cae; el cierre de planes de Medicare Advantage que denuncian divulgadores de finanzas personales y la llamada de «historia de recuperación» en televisión se leen como dos caras del mismo recorte de afiliados [108, 109].
MarketBeat (flujo de noticias y titulares sobre UNH)	2026-10	40	Dividido	Titulares de la semana previa a resultados muy repartidos: gestoras que suben y que recortan posición, avances que dudan si la acción subirá o bajará tras el 3T, artículos de «ganga» junto a una nota de un bufete que investiga si los directivos incumplieron sus deberes fiduciarios [112].

Tema	Postura	Peso	Qué dicen los datos
Ratio de siniestralidad (MCR) y recuperación de márgenes: los resultados del 3T26 como prueba	Alcista	Alto	El 86,7 % del 2T26 incluía 860 M de desarrollo favorable de ejercicios anteriores y la guía anual es de 88,1 % ± 25 pb, lo que implica un MCR más alto en el segundo semestre por pura estacionalidad: quien espera «mantener o bajar» el 86,7 % en el 3T pide más de lo que la propia guía promete [105].
Valoración tras el rebote desde el mínimo de marzo: ¿queda recorrido?	Dividida	Alto	La acción subió de 255,97 USD (27-mar) a 461,62 USD (16-jul) y cerró a 379,30 USD el 9-oct; los foros se parten entre «más barata cada vez» y «el potencial se ha agotado», sin que nadie discuta que el precio ya no es de capitulación [100, 102, 111].
Medicare Advantage: cierre de planes, pérdida de afiliados, tarifas y estrellas de 2027	Dividida	Medio	Para unos el recorte de afiliados es la disciplina de precios que explica la mejora del margen; para otros, una pérdida de cuota frente a Humana, que mejora sus estrellas; la cifra de afiliados perdidos que circula hay que comprobarla en el 10-Q del 2T26 [108, 109].
Coste del negocio comercial (GLP-1, fármacos antiinflamatorios, arbitrajes de facturación)	Bajista	Medio	La propia dirección dijo en la conferencia del 2T26 que la recuperación del margen comercial llevará más de lo previsto: es el riesgo que la gente sí ha recogido y que explica parte de la caída desde julio [101, 102].
DOJ, litigios y gobierno (vuelta de Hemsley)	Bajista	Bajo	Apenas aparece en lo leído: solo un titular de un bufete sobre posibles incumplimientos de deberes fiduciarios; las investigaciones del DOJ siguen abiertas según la empresa, así que la escasa atención de los particulares puede infravalorar un riesgo binario [112].

El sentimiento no es extremo: ni la capitulación de marzo ni la euforia de julio. Los particulares que escriben se han enfriado (el indicador de carteras de TipRanks marca salidas y los colaboradores de Seeking Alpha publican rebajas y tesis de «potencial agotado»), mientras blogueros y analistas siguen mayoritariamente alcistas [100, 106, 107]. Eso va en contra del consenso profesional y deja la acción expuesta a una lectura exigente del 3T26: el mercado de opciones descuenta un movimiento de alrededor del 7 % [107]. El foco casi exclusivo en el MCR del trimestre es un riesgo, porque la guía anual ya implica un segundo semestre peor que el 2T. Llama la atención que el DOJ y el gobierno casi no se discutan: si hubiera novedades, el mercado no las tiene descontadas.

Opiniones de inversores en foros, redes y comentarios de prensa: sirven para saber qué preocupa o entusiasma al mercado, no como fuente de cifras. No entran en la valoración.

Anexos

A. Controles de calidad del análisis

18 de 18 controles correctos. Fuentes: 112 (64 primarias); citas distintas en el texto: 112.

Control	Resultado	Detalle
Geografías suman 100 %	OK	–
DCF inverso calculable	OK	–
Puente de ingresos (volumen + precio + otros) = crecimiento del DCF	OK	–
Circulante del primer año de proyección ≈ último real	OK	Supuesto -2,6 % frente a -2,6 % real: genera una variación de circulante de 77 M en el primer año. Converge de forma gradual.
Peso del valor terminal ≤ 80 % del valor empresa	OK	71 %.
Crecimiento a perpetuidad ≤ 3 %	OK	3,00 %.
Probabilidades de los escenarios suman 100	OK	–
Al menos 5 comparables	OK	8 comparables.
Pesos de la síntesis suman 100	OK	–
Múltiplos del objetivo a 12 m según la regla común	OK	–
Objetivo 12 m frente al consenso	OK	El base se separa un -2,4 % del objetivo medio de los analistas: explícalo en diferencia_consenso (nunca se acerca la cifra).
Precio del cierre de la fecha de corte (o de las dos sesiones anteriores)	OK	–
Recomendación coherente con la regla de decisión	OK	–
La síntesis explica la convicción	OK	La síntesis debe decir por qué tiene esa convicción y qué la subiría o la bajaría.
Al menos 25 fuentes	OK	112 fuentes (64 primarias).
Al menos 10 fuentes primarias	OK	64.
Toda cita [n] existe en fuentes	OK	–
Fuentes sin citar ≤ 15 %	OK	–

Tipo de fuente	Número
Primaria	64
Prensa	15
Sectorial	7
Datos de mercado	12
Analistas	11
Foros y redes	3

B. Información no disponible

Cuando un dato no aparece tras tres búsquedas distintas, el análisis lo deja fuera en lugar de estimarlo sin base. Las secciones de núcleo que faltan se avisan también en el resumen.

Sección	Dato que falta	Tipo	Las tres búsquedas	Decisión
trimestres	ultima_presentacion (transcripción del 1T26)	Complemento	1) Búsqueda web de la transcripción del 1T26; 2) Insider Monkey: solo publica el arranque, el resto tras registro; 3) AOL/Motley Fool: la dirección da 404	Omitido
trimestres	vs_consenso (salvo 1T26)	Complemento	1) Notas de prensa de la empresa (no dan consenso); 2) transcripción del 2T26 de Motley Fool (no da el consenso previo); 3) búsqueda web de la transcripción del 1T26 (solo da el del 1T26)	Omitido
balance	vida_media_anios	Complemento	1) Nota 8 del 10-K 2025 (solo vencimientos por año); 2) 10-Q del 2T26 (remite al 10-K); 3) XBRL companyfacts (sin dato de vida media)	Omitido
balance	extra.caja_no_regulada (2016, 2017, 2019, 2020, 2022 y 2023)	Complemento	1) 10-K 2018 (solo da 2018); 2) 10-K 2021 (solo 2021); 3) 10-K 2024 (solo 2024); no se bajaron los 10-K de esos años por tiempo	Omitido
flujos	desinversiones 2016-2019	Complemento	1) XBRL ProceedsFromDivestitureOfBusinesses (empieza en 2020); 2) 10-K 2018 (no hay línea separada en el estado de flujos); 3) 10-K 2021 (desde 2019 sin dato separado)	Omitido
esg	calificaciones (MSCI ESG Rating)	Complemento	1) Página de la empresa en Sustainalytics/MSCI (carga con JavaScript, sin dato); 2) búsqueda web de la nota MSCI de UNH (sin letra publicada en abierto); 3) MarketScreener y Yahoo Finance (solo descripción cualitativa o puntuaciones de Sustainalytics sin fecha)	Omitido
negocio	segmentos (ejercicio 2021 y reexpresión de 2026)	Complemento	1) 10-K 2025 (2023-2025); 2) 10-K 2024 (2022); 3) el 10-K 2023 no se descargó por presupuesto; la reexpresión de 2026 (Optum Bank pasa a Optum Insight) solo está en los 10-Q de 2026	Omitido
comparables	ev_ebitda_ntm de los comparables	Complemento	1) StockAnalysis forecast: solo ingresos y BPA (EBITDA previsto de pago); 2) MarketScreener: no consultado para los ocho comparables por presupuesto de llamadas; 3) cálculo con el margen LTM: descartado por mezclar definiciones	Omitido
sentimiento	revisadas (foros con comentarios de particulares: Stocktwits, Seeking Alpha comentarios, Rankia, InvestorsHub, Stockhouse, Investing.com)	Complemento	1) Stocktwits (API y web), artículos de Seeking Alpha e Investing.com con WebFetch y descargar.mjs: HTTP 403; 2) InvestorsHub y Stockhouse: HTTP 403; Rankia: sin hilo propio de UNH localizable (la etiqueta y la búsqueda llevan a hilos ajenos o 404); 3) se sustituye por titulares de colaboradores de Seeking Alpha, el indicador de particulares de TipRanks y artículos de opinión para particulares (Motley Fool, Insider Monkey, 24/7 Wall St.)	Calculado y marcado como estimación

Fuentes

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
1	UnitedHealth Group, Form 10-K del ejercicio 2025	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	2 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000062/unh-20251231.htm
2	UnitedHealth Group, Form 10-K del ejercicio 2024	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	27 feb 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000063/unh-20241231.htm
3	UnitedHealth Group, Form 10-K del ejercicio 2021	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	15 feb 2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176622000008/unh-20211231.htm
4	UnitedHealth Group, Form 10-K del ejercicio 2018	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	12 feb 2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176619000005/unh2018123110-k.htm
5	UnitedHealth Group, Form 10-Q del segundo trimestre de 2026	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	10 ago 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000197/unh-20260630.htm
6	UnitedHealth Group, Form 10-Q del primer trimestre de 2026	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	5 may 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000127/unh-20260331.htm
7	UnitedHealth Group, Form 10-Q del tercer trimestre de 2025	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	28 oct 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000305/unh-20250930.htm
8	Nota de prensa de resultados del 2T26 (exhibit 99.1)	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	16 jul 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000191/earningsrelease2q26_7152.htm
9	Nota de prensa de resultados del 1T26 (exhibit 99.1)	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	21 abr 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000121/earningsrelease1q26press.htm
10	Nota de prensa de resultados de 2025 y guía 2026 (exhibit 99.1)	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	27 ene 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000025/a991unherq42025.htm
11	Nota de prensa de resultados del 3T25 (exhibit 99.1)	UnitedHealth Group (SEC EDGAR)	Primaria	28 oct 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000301/a2025q3exhibit991.htm
12	Datos XBRL de UnitedHealth Group (companyfacts, CIK 731766)	SEC	Primaria	12 oct 2026	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000731766.json

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
13	UnitedHealth (UNH) Q2 2026 Earnings Call Transcript	The Motley Fool (vía Mitrade)	Prensa	17 jul 2026	https://www.mitrade.com/insights/news/live-news/article-8-1910297-20260717
14	UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) Q1 2026 Earnings Call Transcript	Insider Monkey	Prensa	21 abr 2026	https://www.insidermonkey.com/blog/unitedhealth-group-incorporated-nyseunh-q1-2026-earnings-call-transcript-1743818/
15	NHE Fact Sheet (National Health Expenditures 2024)	CMS, Office of the Actuary	Sectorial	jun 2026	https://www.cms.gov/data-research/statistics-trends-and-reports/national-health-expenditure-data/nhe-fact-sheet
16	National Health Expenditure Projections 2025-2034: Forecast Summary	CMS, Office of the Actuary	Sectorial	24 jun 2026	https://www.cms.gov/files/document/nhe-projections-forecast-summary.pdf
17	NHE Projections 2025-2034, Table 1: National Health Expenditures and Selected Economic Indicators	CMS, Office of the Actuary	Sectorial	24 jun 2026	https://www.cms.gov/files/zip/nhe-projections-tables.zip
18	Medicare Advantage in 2026: Enrollment Update and Key Trends	KFF	Sectorial	5 jun 2026	https://www.kff.org/medicare/medicare-advantage-in-2026-enrollment-update-and-key-trends/
19	Elevance Health, informe anual 10-K 2025	Elevance Health (SEC)	Primaria	6 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156039/000115603926000013/elv-20251231.htm
20	The Cigna Group, informe anual 10-K 2025	The Cigna Group (SEC)	Primaria	26 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1739940/000173994026000006/ci-20251231.htm
21	CVS Health, informe anual 10-K 2025	CVS Health (SEC)	Primaria	10 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000006480326000010/cvs-20251231.htm
22	Humana, informe anual 10-K 2025	Humana (SEC)	Primaria	19 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49071/000004907126000009/hum-20251231.htm
23	Centene, informe anual 10-K 2025	Centene (SEC)	Primaria	17 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1071739/000107173926000049/cnc-20251231.htm
24	Molina Healthcare, informe anual 10-K 2025	Molina Healthcare (SEC)	Primaria	10 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1179929/000117992926000005/moh-20251231.htm
25	2027 Medicare Advantage and Part D Rate Announcement (fact sheet)	CMS	Primaria	6 abr 2026	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/2027-medicare-advantage-part-d-rate-announcement

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
26	2027 Medicare Advantage and Part D Advance Notice (fact sheet)	CMS	Primaria	26 ene 2026	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/2027-medicare-advantage-part-d-advance-notice
27	2026 Medicare Advantage and Part D Rate Announcement (fact sheet)	CMS	Primaria	7 abr 2025	https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/2026-medicare-advantage-part-d-rate-announcement
28	The Top Pharmacy Benefit Managers of 2025	Drug Channels Institute	Sectorial	30 mar 2026	https://www.drugchannels.net/2026/03/the-top-pharmacy-benefit-managers-of.html
29	Competition in Health Insurance: A Comprehensive Study of U.S. Markets (actualización 2025, datos 2024)	American Medical Association	Sectorial	dic 2025	https://www.ama-assn.org/system/files/competition-health-insurance-us-markets.pdf
30	UnitedHealth Group, 8-K (punto 8.01) sobre las investigaciones del DOJ	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	24 jul 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000224/unh-20250723.htm
31	UnitedHealth Group, 8-K (punto 5.02): dimisión de Andrew Witty como consejero	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	20 may 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000150/unh-20250520.htm
32	UnitedHealth Group, proxy statement (DEF 14A) 2026	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	21 abr 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000110465926046125/tm261387-6_def14a.htm
33	UnitedHealth Group (artículo de enciclopedia)	Wikipedia	Prensa	oct 2026	https://en.wikipedia.org/wiki/UnitedHealth_Group
34	Chairman Guthrie Celebrates Long-Awaited PBM Reform Being Signed into Law	Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE. UU.	Primaria	5 feb 2026	https://republicans-energycommerce.house.gov/posts/chairman-guthrie-celebrates-long-awaited-pbm-reform-being-signed-into-law
35	UnitedHealth Group (UNH): ficha con riesgo ESG de Morningstar Sustainalytics	Saxo Bank	Datos de mercado	oct 2026	https://www.home.saxo/en-gb/markets/stocks/unh-xnys
36	UnitedHealth Group, informe anual 10-K 2015 (compra de Catamaran)	UnitedHealth Group (SEC)	Primaria	feb 2016	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176616000058/unh2015123110-k.htm
37	Form 8-K (Item 5.02): salida de Andrew Witty y nombramiento de Stephen Hemsley como CEO	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	14 may 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000134/unh-20250512.htm
38	Form 8-K (Item 5.02): nombramiento de Wayne DeVeydt como CFO	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	31 jul 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000232/unh-20250725.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
39	Form 8-K (Item 5.07): resultados de la junta de 2024	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	7 jun 2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176624000167/unh-20240603.htm
40	Form 8-K (Items 5.02 y 5.07): junta de 2025 y cancelación de las PSU de Witty	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	4 jun 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000154/unh-20250602.htm
41	Form 8-K (Item 5.07): resultados de la junta de 2026	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	5 jun 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000138/unh-20260601.htm
42	Form 8-K (Item 5.02): obligación de mantener las acciones de la opción de Hemsley hasta 2030	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	25 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000046/unh-20260223.htm
43	Form 8-K (Item 5.02): nombramiento de Scott Gottlieb como consejero independiente	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	21 nov 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000314/unh-20251118.htm
44	Form 8-K (Item 5.02): nuevo Chief Accounting Officer	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	2 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000064/unh-20260224.htm
45	Form 8-K (Item 5.02): Cianfrocco a Gobierno y Cumplimiento; Conway, CEO de Optum	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	29 abr 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000125/unh-20250429.htm
46	Form 4 de consejeros y directivos de UnitedHealth Group (abr-2025 a oct-2026)	SEC EDGAR	Primaria	12 oct 2026	https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000731766&type=4
47	Schedule 13G/A de The Vanguard Group (10,08 %)	SEC EDGAR	Primaria	7 may 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000093247125000662/
48	Schedule 13G/A de The Vanguard Group (realineamiento interno, 0 %)	SEC EDGAR	Primaria	27 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000010290926002526/
49	Schedule 13G de Vanguard Capital Management (7,50 %)	SEC EDGAR	Primaria	30 abr 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000210011926001233/
50	Schedule 13G de State Street Corporation (5,0 %)	SEC EDGAR	Primaria	7 ago 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000093751260000551/
51	Guía 2023 presentada en el Investor Conference (8-K, Ex. 99.1)	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	29 nov 2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176622000048/a2022investorconferencegui.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
52	Guía 2024 presentada en el Investor Conference (8-K, Ex. 99.1)	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	28 nov 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176623000080/a2023investorconferencegui.htm
53	Nota de prensa de resultados del 4T23	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	12 ene 2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176624000023/a2023q4exhibit991.htm
54	Nota de prensa de resultados del 4T24	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	16 ene 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000022/a2024q4exhibit991.htm
55	Nota de prensa de resultados del 1T25	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	17 abr 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000123/a2025q1exhibit991.htm
56	Nota de prensa: cambio de CEO y suspensión de la guía 2025 (8-K, Ex. 99.1)	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	13 may 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000134/exhibit991.htm
57	Nota de prensa de resultados del 2T25	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	29 jul 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176625000228/a2025q2exhibit991.htm
58	Nota de prensa de resultados del 1T26	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	21 abr 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000073176626000121/
59	Form 13F-HR de Berkshire Hathaway, 2T25 (tabla de posiciones)	Berkshire Hathaway / SEC	Primaria	14 ago 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000095012325008343/43977.xml
60	Form 13F-HR de Berkshire Hathaway, 4T25 (tabla de posiciones)	Berkshire Hathaway / SEC	Primaria	17 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000119312526054580/50240.xml
61	Form 13F-HR de Berkshire Hathaway, 1T26 (tabla de posiciones, sin UNH)	Berkshire Hathaway / SEC	Primaria	15 may 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000119312526226661/53405.xml
62	Final judgment reached in DOJ's Amedisys-UnitedHealth Group lawsuit	Hospice News	Prensa	12 dic 2025	https://hospicenews.com/2025/12/12/final-judgement-reached-in-in-dojs-amedisys-unitedhealth-group-lawsuit/
63	Judge lets CalPERS lawsuit against UnitedHealth proceed in part	Claims Journal	Prensa	1 oct 2026	https://www.claimsjournal.com/news/national/2026/10/01/340484.htm
64	Históricos diarios de UNH, SPY y XLV	Yahoo Finance	Datos de mercado	9 oct 2026	https://finance.yahoo.com/quote/UNH/history

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
65	UnitedHealth Group: previsiones financieras (finances)	MarketScreener	Analistas	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/UNITEDHEALTH-GROUP-INC-14750/finances/
66	UnitedHealth Group: consenso de analistas	MarketScreener	Analistas	12 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/UNITEDHEALTH-GROUP-INC-14750/consensus/
67	UNH stock forecast (consenso de S&P Global)	StockAnalysis	Analistas	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/unh/forecast/
68	UnitedHealth Group Announces Earnings Release Date (Business Wire, 15-sep-2026)	Finviz / Business Wire	Primaria	15 sep 2026	https://finviz.com/news/392380/unitedhealth-group-announces-earnings-release-date
69	Elevance Health (ELV) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/elv/statistics/
70	The Cigna Group (CI) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/ci/statistics/
71	CVS Health (CVS) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/cvs/statistics/
72	Humana (HUM) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/hum/statistics/
73	Centene (CNC) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/cnc/statistics/
74	Molina Healthcare (MOH) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/moh/statistics/
75	Oscar Health (OSCR) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/oscr/statistics/
76	Alignment Healthcare (ALHC) statistics	StockAnalysis	Datos de mercado	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/alhc/statistics/
77	Elevance Health (ELV) forecast	StockAnalysis (S&P Global)	Analistas	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/elv/forecast/
78	The Cigna Group (CI) forecast	StockAnalysis (S&P Global)	Analistas	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/ci/forecast/
79	CVS Health (CVS) forecast	StockAnalysis (S&P Global)	Analistas	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/cvs/forecast/
80	Humana (HUM) forecast	StockAnalysis (S&P Global)	Analistas	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/hum/forecast/
81	Centene (CNC) forecast	StockAnalysis (S&P Global)	Analistas	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/cnc/forecast/
82	Molina Healthcare (MOH) forecast	StockAnalysis (S&P Global)	Analistas	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/moh/forecast/
83	Oscar Health (OSCR) forecast	StockAnalysis (S&P Global)	Analistas	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/oscr/forecast/
84	Alignment Healthcare (ALHC) forecast	StockAnalysis (S&P Global)	Analistas	12 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/alhc/forecast/

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
85	10-Year Treasury Constant Maturity Rate (DGS10)	Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)	Datos de mercado	8 oct 2026	https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
86	Implied ERP by month (ERPbymonth.xlsx)	Aswath Damodaran, NYU Stern	Datos de mercado	oct 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERPbymonth.xlsx
87	Betas by Sector (US), enero de 2026	Aswath Damodaran, NYU Stern	Sectorial	ene 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
88	Cigna to Acquire Express Scripts (exhibit 99.1 del 8-K)	Cigna / SEC	Primaria	8 mar 2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/701221/000095015918000059/ex99-1.htm
89	CVS Health to Acquire Aetna (exhibit 99.1 del 8-K)	CVS Health / SEC	Primaria	4 dic 2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000119312517359526/d482402dex991.htm
90	OptumInsight and Change Healthcare Combine (exhibit 99.1 del 8-K)	UnitedHealth Group / SEC	Primaria	6 ene 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/731766/000119312521002419/d60247dex991.htm
91	Amedisys and Optum to Combine (exhibit 99.1 del 8-K)	Amedisys / SEC	Primaria	26 jun 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/896262/000110465923074547/tm2319648d1_ex99-1.htm
92	CVS Health to Acquire Signify Health (exhibit 99.1 del 8-K)	CVS Health / SEC	Primaria	6 sep 2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000119312522238311/d344935dex991.htm
93	Express Scripts Holding, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	feb 2018	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001532063.json
94	Aetna, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	feb 2018	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001122304.json
95	Change Healthcare, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	may 2021	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001756497.json
96	Amedisys, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	may 2023	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0000896262.json
97	Signify Health, datos XBRL (companyfacts)	SEC	Primaria	mar 2022	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001828182.json
98	CVS Health to Acquire Oak Street Health (exhibit 99.1 del 8-K)	CVS Health / SEC	Primaria	8 feb 2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/64803/000094787123000133/ss1747225_ex9901.htm
99	Humana to acquire remaining interest in Kindred at Home (exhibit 99.3 del 8-K)	Humana / SEC	Primaria	28 abr 2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/49071/000004907121000079/exhibit993kindredathome-.htm

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
100	UnitedHealth Group Incorporated - News and Analysis (canal RSS del valor, titulares de agosto a octubre de 2026)	Seeking Alpha	Foros y redes	12 oct 2026	https://seekingalpha.com/api/sa/combined/UNH.xml
101	UnitedHealth Is Trouncing the Market in 2026. Is the Stock Still a Buy?	The Motley Fool	Prensa	4 sep 2026	https://www.fool.com/investing/2026/09/04/unitedhealth-is-trouncing-the-market-in-2026-is-th/
102	UnitedHealth Group Stock Is Up 39.4% in the Last 6 Months. How High Can It Go?	The Motley Fool	Prensa	8 sep 2026	https://www.fool.com/investing/2026/09/08/unitedhealth-group-stock-is-up-39-in-the-last-6-mo/
103	Should You Buy UnitedHealth Group Stock Before Oct. 13?	The Motley Fool	Prensa	21 sep 2026	https://www.fool.com/investing/2026/09/21/should-you-buy-unitedhealth-group-stock-before-oct-13/
104	Is UnitedHealth Stock an Undervalued Stock to Buy Right Now?	The Motley Fool	Prensa	24 sep 2026	https://www.fool.com/investing/2026/09/24/is-unitedhealth-stock-an-undervalued-stock-to-buy/
105	UnitedHealth Reports on Oct. 13. Here's the 1 Number I'm Watching.	The Motley Fool	Prensa	3 oct 2026	https://www.fool.com/investing/2026/10/03/unitedhealth-reports-on-oct-13-heres-the-1-number/
106	UNH Investor Sentiment (Crowd Wisdom y Blogger Sentiment)	TipRanks	Foros y redes	12 oct 2026	https://www.tipranks.com/stocks/unh/investor-sentiment
107	Will UnitedHealth Stock Rise or Fall after Q3 Results?	TipRanks	Prensa	12 oct 2026	https://www.tipranks.com/news/will-unitedhealth-stock-rise-or-fall-after-q3-results
108	Humana Soars 16% on Improved Medicare Advantage Star Ratings; CVS Slides 3%, UnitedHealth Holds Steady	24/7 Wall St.	Prensa	9 oct 2026	https://247wallst.com/investing/2026/10/09/humana-soars-16-on-improved-medicare-advantage-star-ratings-cvs-slides-3-unitedhealth-holds-steady/
109	Suze Orman Warned 390,000 People Their Medicare Plans Are Shutting Down. Then CNBC Called the Same Stock a Turnaround	24/7 Wall St.	Prensa	7 oct 2026	https://247wallst.com/personal-finance/2026/10/07/suze-orman-warned-390000-people-their-medicare-plans-are-shutting-down-then-cnbc-called-the-same-stock-a-turnaround/
110	Does UnitedHealth (UNH) Present a Case for Patience in a Margin-Repair Story?	Insider Monkey	Prensa	9 oct 2026	https://www.insidermonkey.com/news/does-unitedhealth-unh-present-a-case-for-patience-in-a-margin-repair-story-1849912/
111	UnitedHealth's P/E Has Reset. Is the Stock Finally Undervalued?	Insider Monkey (en Yahoo Finance)	Prensa	8 oct 2026	https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/unitedhealth-p-e-reset-stock-070435587.html
112	UnitedHealth Group (UNH) News Today	MarketBeat	Foros y redes	12 oct 2026	https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/UNH/news/

Control de calidad del informe

Campos con dato: **93,4 %** · Secciones con menos del 60 % de campos cubiertos: **ninguna** · Generado el 14 oct 2026.

Precio de cierre del viernes 9-oct-2026: la sesión del lunes 12-oct, fecha de corte, no había cerrado. Los resultados del 3T26 se publican el 13-oct-2026, al día siguiente del corte, y no se recogen. Criterio de flotante: UnitedHealth es una aseguradora de salud con reservas de cola corta; el EBITDA incluye el rendimiento de las inversiones de las filiales reguladas («investment and other income», 3.920 M en 2025) y, por coherencia, la caja e inversiones de esas filiales quedan fuera del puente (solo cuentan los 1.100 M de caja no regulada a 30-jun-2026), y los «medical costs payable» y los ingresos cobrados por anticipado quedan fuera del circulante comercial. El balance histórico conserva la caja publicada (caja + inversiones a corto), por lo que la deuda neta histórica y el ROIC del motor no son del todo homogéneos con el puente. Los segmentos de 2016-2025 son los publicados en su día (no reexpresados por el paso de Optum Financial a Optum Insight en 2026). Los múltiplos de los comparables son de Stock Analysis, cuyo valor empresa resta la caja regulada de las aseguradoras: por eso la síntesis usa solo su PER.

Este documento es un análisis elaborado de forma automatizada a partir de fuentes públicas. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni una oferta de compra o venta. Las cifras marcadas como estimación y los escenarios son hipótesis de trabajo y deben verificarse antes de tomar cualquier decisión.